

分类号：

单位代码 :10441

密 级：

学 号 : 201602126

 山东中医药大学
硕 士 学 位 论 文

中文题目：田代华月经病学术思想及临证经验研究

英文题目：Study of Profess or Tian Daihua's
Academic Thoughts on Menstrual
Diseases and Clinical Experience of
Evidence

申请人姓名	张程程
入学年月	2016 年 9 月
学科专业	中医医史文献
指导教师	张成博教授
学位类型	医学科学学位

提 要

目的：归纳总结田代华教授对月经病治疗的学术思想、临床常用药方、药物等。

方法：1. 运用文献学方法搜集月经病的相关文献资料，并通过跟师随诊、查阅相关论文著作文稿、拜访请教田代华教授等方式收集整理其治疗月经病资料，二者结合。
2. 收集田代华教授多年月经病门诊病历，对处方进行处理，并分析药物使用规律。

结果：正文分三部分进行研究。第一部分通过对田代华教授生平、治学经验的整理，不仅能了解一代名老中医的成长历史，且能从其成长中究其思想渊源，有利于探求理解其治疗月经病的学术思想。对其学术观点与特色进行简单梳理，更好理解其治疗月经病的思想及经验。第二部分为研究整理田代华教授治疗月经病的学术思想，认为脾肾功能的正常与气血的调畅是月经正常潮泄的基础与前提，同时强调年龄与体质对月经的影响。第三部分为临证经验，总结月经病常用方并对用药规律进行分析讨论。

结论：田代华教授强调脾肾对女性月经病的重要性，认为临床常见月经病发病体质多为气血偏颇体质，且常复合出现。总结了临床治疗月经病的常用方药，多为健脾补肾、调理气血之方药，且在临证时将基础方与疾病用药相结合，使方药运用与患者的病情更加吻合，收效甚佳。

关键词 田代华；月经病；脾肾；气血；体质

Study of Professor Tian Daihua's Academic Thoughts on Menstrual Diseases and Clinical Experience of Evidence

Speciality:History and Literature of TCM

Author:Zhang Chengcheng

Tutor: Professor Zhang Chengbo

Abstract

Objective: In order to summarize Professor Tian Daihua's academic thoughts on the treatment of menstrual diseases, common clinical prescriptions, commonly used drugs and so on.

Methods: 1. Through the literature method to collect the relevant literature of menstrual diseases, and through the consultation with the teacher, access to the relevant papers, successive postgraduate papers and visits to ask Professor Tian Daihua and other ways to collect and organize their treatment of menstrual disease information, the combination of the two, summed up Professor Tian Daihua's academic thinking in the treatment of menstrual diseases. 2. Collect Professor Tian Daihua's medical records of menstrual diseases for many years and standardize the prescription, summarize his experience of menstrual syndrome, and analyze the rules of drug use.

Results: The text is divided into three parts for study. The first part, through the collation of Professor Tian Daihua's life and study experience, can not only understand the growth history of a generation of old Chinese medicine, but can learn from its growing ideological origin, which is conducive to exploring and understanding its academic thought of treating menstrual diseases. This paper makes a simple combing of its academic views and characteristics, and better understands its thoughts and experiences in the treatment of menstrual diseases. The second part is to study and collate the academic thoughts of Professor Tian Daihua in the

treatment of menstrual diseases, and think that the normal spleen and kidney function and the adjustment of Qi and blood are the basis and premise of normal menstrual tide leakage, and emphasize the influence of age and physique on menstruation. The third part is the experience of syndrome, summing up the common side of menstrual disease and analyzing and discussing the law of drug use.

Conclusion: To emphasize the importance of spleen and kidney to female menstrual disease, the clinical common menstrual disease is mostly Qi and blood biased physique, and often complex appearance. Summarize the clinical treatment of menstrual diseases commonly used prescription drugs, mostly spleen and kidney, conditioning Qi and blood prescription, and in the syndrome will be the basic side and disease drug combination, so that the use of prescription and the patient's condition more consistent.

Keywords Tian Daihua; menstrual disease; spleen and kidney; Qi and blood; physique

目 录

引 言	1
第一部分 田代华教授生平、治学及学术特色	3
一、田代华教授生平	3
二、治学精神	4
(一) 活学巧记 积基树本	4
(二) 勤求古训 博采众长	5
(三) 博极医源 精勤不倦	6
(四) 医德高尚 杏林春暖	7
三、学术观点与特色	8
(一) 三要素辨证体系	8
(二) 中西对应 病证结合	9
(三) 脏腑与气血并重	10
(四) 专病专药 擅用药对	10
第二部分 田代华教授月经病学术思想	11
一、月经病病因病机随年龄各有侧重	11
(一) 青春期	11
(二) 生育期	14
(三) 更年期	16
二、强调脏腑气血对月经作用	18
(一) 月经失调 脾肾为先	18
(二) 以血为本 以气为用	24

三、体质对月经影响	25
(一) 月经病与体质的关系	26
(二) 不同体质的月经病证候	28
第三部分 田代华教授月经病临证经验及用药分析	31
一、月经病基本治疗原则	31
(一) 补肾益精	31
(二) 健脾和胃	33
(三) 调理气血	35
二、月经病体质及治疗	37
(一) 常见月经病体质及治疗	38
(二) 各年龄阶段体质及治疗	40
三、月经病用药规律数据分析	42
(一) 资料与方法	43
(二) 结果	44
(三) 讨论	47
结 语	50
参考文献	51
附 录	54
致 谢	62
论文著作	64

引 言

研究名老中医的学术思想和临床经验,是继承中医药理论体系和临证经验诊疗技术,提高中医临床服务水平的需要,也是推动中医学术进步和理论创新的需要。田代华教授作为山东省名中医专家,从事临床工作数十年,经验丰富,擅长心脑血管疾病、月经病、妇科杂病、脾胃病、情志病及各种疑难杂症。选取田代华教授治疗月经病作为研究,有助于继承发展其治疗妇人疾病的思想及临证经验。田代华教授虽不是专攻月经病,但其在月经病学术方面有一定见解,临证方法也颇具特色,临床收效甚佳。

月经是指胞宫周期性出血的生理现象,从月经初潮开始到自行停经,除去妊娠及哺乳期外,月经通常按月来潮,信而有期,故称为月经,又称为月事、月信、月水等,正如李时珍《本草纲目·妇人月水》所云:“女子,阴类也,以血为主。其血上应太阴,下应海潮。月有盈亏,潮有朝夕,月事一月一行,与之相符,故谓之月水、月信、月经。经者常也,有常轨也。”^{[1]1202} 月经除每月一至,也有其它特殊情况,属正常现象,如《医宗金鉴·妇科心法要诀·月经之常》云:“女子月经一月一行者,其常也。或先或后,乃其病也。然亦有两月一行,谓之并月者;有三月一行,谓之居经者;有一年一行,谓之避年者;有一生不行而依然能孕育,谓之暗经者。此所禀之不同,而亦非病,不须治也。”^{[2]418} 现一般认为月经的产生,是女子机体发育至成熟后,脏腑、天癸、气血、经络协调作用于胞宫的正常生理现象。西医认为月经是指伴随卵巢周期性排卵,卵巢分泌雌、孕激素的周期性变化所引起的子宫内膜周期性脱落及出血。^{[3]15}

月经病则是指以月经的周期、经期、经量异常为主证,或伴随月经周期,或于经断前后出现明显症状为特征的疾病。^{[3]69} 《妇科玉尺》云:“经贵乎如期。若来时,或前或后,或多或少,或月二三至,或数月一至,皆为不调。不调则病作,甚至积而不行,则病更作。”^{[4]13} 临床常见月经病有月经先期、月经后期、月经先后无定期、月经过多、月经过少、经间期出血、崩漏等,常见伴随症状有头痛、身痛、乳房胀痛、泄泻、失眠、情绪不稳定、呕吐、全身浮肿等。月经病严重时则会影响正常的生活和社会活动,是妇科的常见病、多发病,被列为妇科病之首。月经病产生的主要病机为脏腑功能失调,气血不和,导致冲任二脉及胞宫的损伤。病因主要为外感邪气、内伤七情、房劳多产、饮食失宜、劳逸失度和体质因素等。

名老中医经验的总结不仅能丰富中医学的理论体系,还能对中医药学术进步产生

巨大的推动作用；名老中医的学术传承是培养造就新一代名中医的重要途径之一。因此，总结名老中医的临床经验、用药规律和学术思想，对中医药的薪火相传具有重要的理论意义和应用价值，也是中医药创新发展的源泉。而方剂作为中医药临床应用的主要形式和手段，对方剂的组方用药规律进行研究和总结，是传承中医防治疾病方法和手段的核心和关键。挖掘名医名家的用药经验和组方规律，是中医药传承与创新的关键问题之一。^{[5]2-3}故本论文除研究田代华教授治疗月经学术思想及临证经验外，尚利用数据挖掘技术对其月经病医案中的组方用药规律进行分析。数据挖掘将人工智能、模式识别、统计学、数据库及计算机等技术相结合，可以从海量数据中提取和发现规律性认识和隐性知识。如今对名老中医医案进行数据挖掘分析技术已日渐成熟，并取得了较好成绩。对田代华教授治疗月经病做更深层次的挖掘，有利于现代名老中医临床经验的继承推广，同时也可以为现代中医医案文献的整理分析提供方法学思路。

第一部分 田代华教授生平、治学及学术特色

一、田代华教授生平

田代华，字莲花，1942年12月出生于山东省汶上县。先生8岁入小学，14岁考入嘉祥县第二中学，1959年升入郓城第十四中学。因其母病逝及自身患病经历，先生立志学医，业岐黄之术，于1962年考入山东中医学院中医系。1968年毕业于山东中医学院，被分配至汶上县南站卫生院任中医师，1971年调入山东医学院，1976年转山东中医学院，^[6]在中医基础教研室担任教学工作。1977年~1987年间被选为山东省第五届、第六届人民代表大会代表。1981年晋升为讲师，1985年5月我校中医文献研究所成立，遂调任副所长。1986年晋升为副教授，任硕士研究生导师，1993年晋升为教授，评为博士研究生导师，1994年被国务院批准享受政府特殊津贴。1995年后，山东中医药大学文献所中医医史文献专业先后被评为山东省、国家中医药管理局和教育部重点建设学科，先生被确定为中医基础理论与临床文献研究的学术带头人。

先生从医50余年，在中医基础、中医文献和中医临床等方面具有深厚的学术造诣，是全国知名的中医医史文献专家。多年来一直致力于中医基础理论与临床应用的文献研究，博极医源，精勤不倦，阅读了大量中医古籍，积累了许多文献资料，整理和创作了一大批学术著作，在此基础上提出了个人的学术观点，创立中西对应、病证结合、三要素（病因、病位、体质）辨证的学术体系，为继承发扬中医学术做出了重要贡献。2001年被中国中西医结合学会授予中西医结合贡献奖，同年被评为山东省科技创新人才，2007年被评为山东省著名中医专家，2010年被收录《名老中医之路》（续编）中，公认为全国著名中医专家。2017年7月成立田代华全省名中医专家传承工作室。多年来，田代华教授共培养硕士生16人，博士生21人，均成为中医教学、科研和临床医疗的重要骨干。

先生在教的同时，还主持了大量中医科研工作，发表专业论文50余篇，编撰或校注学术著作及中医古籍40余部。其中，主编有大型辞书《实用中药辞典》，及《中医文献导读》《传统中医学理论》《实用中医对药方》《实用中医三味药方》《校勘学》《中医览胜》《中医防病与保健》《心理与健康》等；副主编有《中医妇科基础理论》《中医方剂大辞典》《实用中医保健学》《中医文献学》《实用汉英中医辞典》《中国历代名医百家传》等；并参加了《中华本草》《素问校释》《针灸甲乙经校注》《灵枢经

语释》等大型文献著作的编写工作；主持校注的中医古籍有《胎产心法》《妇人大全良方》《黄帝内经素问》《黄帝内经素问校注》《灵枢经》《灵枢经校注》《素问注证发微》《灵枢注证发微》《医学入门》《医学心悟》《活幼心书》《古今名医方论》《先醒斋医学广笔记》《鲁府禁方》《奇效良方》《刘涓子鬼遗方》《疡科心得集》《世医得效方》等。获得的科研奖励有：国家科学委员会科技进步三等奖 1 项；国家中医药管理局基础研究一等奖 1 项，科技进步二等奖 2 项，三等奖 1 项；山东省教育委员会科技进步二等奖 2 项，三等奖 2 项等。^{[7]343-344}

二、治学精神

先生从事中医教学、科研 40 余年，始终兢兢业业，为学生传道授业，解惑答疑，潜心研究古籍文献。从事中医临床工作数十年，深得病患信任，积累了丰富的治学经验。

（一）活学巧记 积基树本

汉代刘向《说苑·谈丛》有云：“山以陵尺故能高。”先生认为，学习中医必须要夯实基础，积基树本，才能厚积而薄发。背诵是学习中医必备的技能，但中医知识晦涩难懂，照本宣科的背诵容易顾此失彼，不能很好的理解其中真谛，所以先生强调背诵要讲究方法技巧，而不是死记硬背。

先生学习中医时曾根据每门课程的特点，认真地将每一门功课都重新整理一遍，变成自己的学习笔记，并取名为“中医万宝囊”。比如学习《内经》时先生为了加深记忆，在小本子上重新抄写重要条文，随身携带，方便随时背诵，取得了较好的效果，现在对于《内经》的重要原文，先生还能张口即来。对于容易混淆，繁琐难记的《中药学》，先生依据当时的教材，将各类药物编成口诀。如将辛温解表药编成“麻桂紫荆羌，防芷藁细姜，葱荳桤柳香”；将辛凉解表药编成“薄牛蝉桑菊，浮蔓淡豆豉，葛柴升贼齐”；将清热泻火药编成“石知梔竹连，三黄苦龙胆”；将利水渗湿药编成“茯猪泽车茵，滑薏冬防心，木通瞿篇石，葵草肤海金”；将祛风湿药编成“独五木威苁，续骨蚕海狗，防豨海络桑，桑虎白乌有”等。然后再区分同类药物的不同之处，就会收到事半功倍的效果。《方剂学》也是一门需要强记的课程，学习的方剂多了就容易出现混淆的情况，于是先生在方歌本上先将每方的功用、主治、病机和方解用钢笔写

在空白处，将容易混淆的地方划出记号，并反复背诵，记忆就容易许多。至今先生在临床上，常用的方剂都能背诵出来，极有利于临床应用。在学习《诊断学》时，先生曾对课本进行过系统整理，对望、闻、问、切四诊列出纲要，望诊以舌诊为重点，舌质有淡、红、绛、紫，舌苔有白、黄、灰、黑、腻、滑等；问诊以张介宾“十问歌”为重点，然后展开记忆；切诊以脉诊为重点，对 28 脉分为浮、沉、迟、数、虚、实六类，将其他脉象分别概括在六类脉象之中，结合《频湖脉学》加以记诵。总之，提纲挈领，抓住重点，再用中医理论进行推导。活学巧记，建立“中医万宝囊”是先生学习中医的有效方法。^{[7]348-350}

观先生之经历，可看出背诵不仅要找到适宜自己的技巧，还要善于总结归纳，化繁为简，灵活推理，所谓“记事者必提其要，纂言者必钩其玄”正是如此。此外，青年人要把握当下，在精力充沛，记忆力最佳的阶段读书、背诵，往往记忆深刻，能终身不忘。先生虽时常感叹在其年老，尤其大病一场后记忆、思维不如从前，但经典条文仍能信手拈来，常用的方剂歌诀、药物口诀仍烂熟于心，临床上运用自如，可见其勤读巧记的扎实功底。

（二）勤求古训 博采众长

先生从事中医教学 40 余年，桃李遍布。在教学上，虽然现在用白话讲解，但先生认为有些问题仍需古典医籍的支持，要想使教学收到良好的效果，必须勤求古训，尤其是中医经典著作。此外，先生认为在教学中还要不断积累经验，要经常向优秀教师学习教学方法，使自己不断进步。如先生曾受教于刘献琳老师，并谨记其教诲：“中医理论来源于《内经》，必须熟读《内经》，才能熟悉中医理论的真谛。”先生之后便更加努力地研读《内经》，并把《内经》原文与中医基础知识相结合，用《内经》理论来阐释，其教学效果逐渐提高，后又将《素问》《灵枢》《类经》系统阅读，以弥补以前的不足。^{[7]355-357}

中医学属于自然科学的范畴，同时具有社会科学的特性，受到古代哲学的影响，是多学科交互渗透的产物。古代的天文、历法、地理、气象、数学以及酿酒技术、冶炼技术等知识，都曾对中医学理论体系的形成与发展起到过重要的促进作用。要理解古医籍文句的内涵底蕴，必须联系相关的医药、文史知识，充分认识古人言论的学术背景、文化背景和历史原因。先生很喜欢古文，教授其古文的解执中老师具有深厚的

古汉语底蕴，不论诗词歌赋、历史典籍还是神话寓言、稗官野史，均可娓娓道来，启发了先生阅读中医古籍的兴趣，奠定了先生整理研究中医古籍的基础。学习《医学史》《哲学》等不仅使先生熟悉历代中医发展概况，伟大医家的成就，而且使先生懂得了唯物主义和辩证法，学会了历史的全面的看待问题，树立了科学的世界观，对其以后的工作具有很大帮助。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，作为中医院校的教师，不仅要有扎实的理论功底，还要有丰富的临床经验。不论是经典著作之精髓还是基础的中医知识，都应与临床实践紧密结合，不可闭门造车，纸上谈兵，实践才能出真知，才能在继承的基础上有所发展，有所创新。先生认为作为医者，要有虚怀若谷、谦逊向贤的美德，不可夜郎自大、刚愎自用。因此，他常常虚心向前贤及同道求教。如先生见习期间常随同学到不同诊室，观摩不同老师临床治疗实践，随时记录老师的经验，参考同学做的诊病记录。^{[7]351}深入民间时，时时处处向当地医生、群众学习，工作之余注意收集当地卫生情况，总结群众防病治病经验，为将来娴熟的临床技术奠定了基础。

退休之后，先生也没有懈怠对学术的探求，时常研读当代名老中医如刘献琳、李克绍、周次清等前辈的学术著作，学习前人的临床经验，博采众长，融会贯通，以弥补自己的不足之处，使医术更加精进。

（三）博极医源 精勤不倦

“尝谓好著书不如多读书，欲读书必先精校书”^[8]，作为山东中医药大学中医文献专业的学术带头人之一，先生从事古籍整理几十年，经过不断的探索规律，积累经验，总结归纳，先后编写《校勘学》《中医文献学》《中医文献导读》等中医文献学专业的专用书目，受到业内的广泛好评，其中部分书籍至今仍在沿用。先生认为中医文献汗牛充栋，浩如烟海，要想有所建树，必须博览群书，不断学习和总结。故其经常到书店浏览，不惜代价购买中医古籍、文史哲重点古书以及字典、辞书等，昼夜研读，废寝忘食，每遇奇妙之处，便抄录一翻，不过数年，便在学术上大有进步。

中医药文献历史悠久，医药典籍成千上万，由于年湮代久，中医古籍历经传抄翻刻，难免出现衍、脱、倒、误等问题，再加上文字的变革，语言的演变，流传至今的古籍读起来常有晦涩难懂之慨，不利于中医学的继承发扬，《广校雠略》有云：“古书流传日久，讹舛滋多，或误夺一字，而事实全乖，或偶衍一文，而意谊尽失，苟非善

读书者据他书订正之，则无以复古人之旧，此校勘之役所以不可缓也……书籍以传钞而衍夺日增，虽一字之微，关系甚大，世之鄙夷校书为小道末技者，岂通识哉！”^[9]充分说明整理校注古籍文献的重要性。先生认为，点校书籍并不是单纯的圈圈点点，将繁体改为简体，校书有时比写书更难。所谓“书三写，鱼成鲁，虚成虎”，如果不经校勘，就会使原文难以理解或致理解错误。

先生认为校勘并非易事，从事校勘工作除具有基本的学问外，还要仔细慎重，广参博览，吃苦耐劳等，其中最重要的一点是切忌乱改。段玉裁云：“凡书必有瑕也，而后以校定自任者出焉。校定之学识不到，则或指瑜为瑕，而疵类更甚，转不若多存其未校定之本，使学者随其学之浅深以定其瑕瑜，而瑕瑜之真固在……古书之坏于不校者固多，坏于校者尤多。坏于不校者，以校治之；坏于校者，久且不可治”。^[11]由此可见，校勘妄改，贻误至深，所以在校勘书籍时，必以把精细谨慎作为第一要务。相传孔子校书不但不轻易改字，而且遇到远古记载有阙文时，也不轻易补字，以保存古书真貌，疑以传疑，留待后人处理。他在校勘中有四条原则“毋意，毋必，毋固，毋我”，毋意，即不妄加猜测；毋必，即不武断专行；毋固，即不固执己见；毋我，即不凭主观臆断。^[12]这种精神对当今校勘工作仍有一定的指导意义。

（四）医德高尚 杏林春暖

孙思邈有云：“人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此。”^{[13]6}说明医乃仁术，欲为良医，有德为先，先生谨记此道，数十年来，始终兢兢业业，热情真诚的对待患者。有些患者因病程年久，倾诉欲望较强，先生会耐心倾听，仔细询问病情，并给予开导。有些患者抱着观望心理前来就诊，有考察之心，诊病之初仅允许察脉，不欲多言，先生不会因此而有微词，而是仔细诊脉，大胆揣测，谆谆善诱，逐步赢得患者的信任与配合，从而展开治疗。先生性格敦厚，谦逊平和，蔼然可亲，每遇纠缠不休，满腹疑问或脾气暴躁的患者，均会耐心认真、不厌其烦的向其解答，不少患者曾夸奖先生“脾气好”“有耐心”。另外，许多因情志致病的患者，先生也会进行劝慰开导，遇到有困难的患者，也会伸出援助之手。

尽管先生自 2012 年后，因身体有恙，行动、书写不如从前，但其仍坚持继续坐诊，无论严寒酷暑，风雨无阻，未曾懈怠。仔细辨证，认真遣方用药，并在处方交于患者手中之前进行二次查验，力求完善无误。先生所救治之患者，遍及全国甚至海外，

不少患者不远千里慕名而来，求治者络绎不绝，常常延误下班至一两点，但先生始终认真对待每一位患者，从不敷衍病人。对于不方便来济南的病人，先生会留给患者自己的电话号码，以便随时掌握病情，及时调方。《灵枢·师传》有云：“人之情，莫不恶死而乐生，告之以其败，语之以其善，导之以其所便，开之以其所苦，虽有无道之人，恶有不听者乎。”^{[14]74}先生在临床上会将治疗的原则、效果、处方中药物的功效，坦率地告诉患者，让患者参与治疗方案的讨论，征求患者的意见。此外，在需要用贵重药物时也会告知患者，尊重患者意愿。有时，会有病号求保健药方，以便平日养生，先生从不私藏，而是根据患者体质与既往病情，开出最适宜的药方，或代茶饮，或嘱其煎服。对于不适合长期服用单一验方的患者，也会向其解释原因。对于自己未曾遇见或不擅长的病情，先生不仅不会欺瞒患者，而是实事求是地向患者说明，或推荐相关领域的专家。先生尊重患者、平等待人、专注病情，医德高尚，深得病人及家属的尊敬，有时患者见先生年迈，久坐诊病，恐其劳累，会主动劝先生休息活动，医患关系十分和谐。

在几十年从医生涯中，先生始终锲而不舍地追求知识，热情真诚地对待患者，实事求是地对待成败，以精湛的医术、渊博的学识、高尚的品德，赢得了广大患者及师生的尊敬及爱戴，桃李天下，杏林春满。

三、学术观点与特色

（一）三要素辨证体系

先生针对中医辨证方法繁多而不统一的现状，收集了临床各科文献，认真分析了形成证候的各种要素，最后认为体质、病因、病位是形成证候的三大要素。先生认为，辨证应在综合临床各种症状和体征的基础上，利用中医基础理论知识，重点分析确定患者的体质、病因和病位，从而做出正确的证候诊断。其中，体质是形成证候的基础，病因是形成证候的诱因，病位是疾病发生的部位。这种诊断方法具有明显的优越性，一是综合了临床各种辨证的纲领，可以形成统一的辨证体系，从而解除中医辨证的多歧之惑；二是能够把握疾病证候的实质，可以形成为医家所公认的规范证候；三是使辨证具有了一定的规律性，简便易学，易于掌握，可使中医辨证理论更具有科学性和实用性。^{[7]370-371}

清代医家徐灵胎在《医学源流论·病同人异论》中指出：“天下有同此一病，而

治此则效，治彼则不惟无效，而反有大害者何也？则以病同而人异也。夫七情六淫之感不殊，而受感之人各殊，或气质有强弱，质性有阴阳，生长有南北，性情有刚柔，筋骨有坚脆，肢体有劳逸，年龄有老少，奉养有膏粱藜藿之殊，心境有忧劳和乐之别，更加天时有寒暖之不同，受病有深浅之各异，一概施治，则病情虽中，而于人之气体迥乎相反，则利害亦相反矣。”^[16]先生认为徐氏虽未明确提出辨证三要素，但已认识到体质、病因、病位在辨证中的重要作用，如文中所言“七情六淫之感”、“天时有寒暖”，乃言病因；“气质有强弱，质性有阴阳”、“性情有刚柔，筋骨有坚脆”，乃言体质；“受病有深浅”，乃言病位。徐氏之论可谓深刻，为先生创立三要素辨证提供了理论支撑。

临床上病证千奇百怪，变化万千，往往要反复揣摩，才可遣方用药，所谓“活泼圆通医家诀，不离不泥是津梁”，不论病证如何纷繁复杂，先生认为准确抓住病因、病位、体质，病证结合，集一方或数方，或扶正或祛邪或扶正兼祛邪，并随证加减，必有疗效。

（二）中西对应 病证结合

先生经过多年文献研究发现，中医早期的文献中是病、证并重的，《内经》《金匱要略》《肘后方》等古医籍均保留了许多古病名；唐宋以后的文献重证轻病，形成以辨证论治为主的医学模式，致使许多古病名被遗忘或失考，丧失了对疾病的深入研究，是中医的一大损失。现在看来，中医病名与西医比较明显不足，不能满足临床需要，有些疾病只能借助西医加以研究，丧失了自身的独立性。先生认为中医要想发展，单纯靠辨证论治是不够的，还应进一步从疾病的角度加以研究，与辨证论治相结合，才能有针对性地加以治疗。所以应重新回顾中医的古病名，与西医的病名对应研究，古代没有的疾病要起新名，或用西医病名代替。^{[7]370}

先生主张凡病人应诊，医者必先用现代手段明确病名诊断，然后再用辨证三要素进行辨证论治，以防止贻误病情。应诊首先要辨明疾病。先生曾举例说：某患者以胃脘部疼痛的症状来就诊，某大夫仅以主诉及兼症“食欲不振，倦怠乏力，面色萎黄，苔薄白，脉沉迟”诊断为胃脘痛，辨证为脾胃虚寒证，治以健脾温中益气，方用附子理中汤与香砂六君子汤加减，服用多剂无明显疗效。后来患者经现代医学手段检查出为胃癌，且已错过了手术时机，贻误了疾病的治疗，为医者当引此为憾事。在疾病发

展过程中，初、中、末等阶段证候往往差别很大，且患者还有体质、年龄差异等因素，因此明确诊断疾病后，再分情况进行辨证论治，辨病与辨证结合，最后确定处方。只有这样才能避免漏诊误诊，提高临床治疗效果。^[15]

（三）脏腑与气血并重

先生认为临床上中医的辨证方法较多，各自有不同的特点与适用范围。但在确定病位、病机时，必须采用脏腑辨证。因为无论外感六淫，或是内伤七情，任何致病因素都是在影响脏腑生理功能的基础上导致的疾病。且人的各项生理活动均依赖于脏腑，各种病理变化亦与脏腑密切相关，疾病的发生、发展，也多数是脏腑功能异常的结果。

先生辨治疾病亦十分重视气血。气血作为维持脏腑功能活动的物质基础，同时又是脏腑活动的产物，如《医醇剩义》有云：“五脏六腑，化生气血；气血旺盛，营养脏腑。”^[17]脏腑发生病变，必将影响气血的正常活动与代谢；而气血发生异常时，又会反作用于脏腑，影响脏腑的正常生理活动。《素问·调经论》云：“五脏之道，皆出于经隧，以行气血，气血不和，百病乃变化而生。”^{[10]227-228}由于气血的病理变化与脏腑密切相关，故先生在临床上常将二者结合辨证，以便更好地对疾病作出诊断。

（四）专病专药 擅用药对

在临床辨证论治中，先生主张专病专药，即根据患者的特殊证候表现加入某些药物，以增强疗效。先生认为，在一张处方中，能发现治疗某种疾病的药物越多，其个体针对性也就越强，该方的疗效也就越好，如失眠患者常加炒枣仁、合欢花、生龙牡；鼻塞不通者，加辛夷、苍耳子、细辛；尿频者常加桑螵蛸、金樱子；心慌、心律不齐者常加苦参、柏子仁；疼痛者加元胡、威灵仙、蜈蚣、全蝎；胃酸过多者，加海螵蛸、煅瓦楞；血糖偏高者常加黄连、天花粉；皮肤瘙痒者常加僵蚕、白鲜皮、地肤子；病毒感染患者常加金银花、蒲公英、板蓝根等等。^[18]

先生曾主编《实用中医对药方》《实用中医三味药方》《实用中药辞典》等中药学专著，遣方用药擅用药对组合。常用药对如山萸肉、怀山药平补肾气；杜仲、桑寄生、川牛膝补肾填精，强腰健骨；当归、丹参、赤芍、红花祛瘀活血；麻黄根、浮小麦收敛止汗；朱砂、琥珀重镇安神；龙骨、牡蛎收敛制酸，重镇安神；苍术、炒白术健脾燥湿；白芥子、土茯苓、清半夏化痰祛瘀解毒等等。

第二部分 田代华教授月经病学术思想

一、月经病病因病机随年龄各有侧重

先生认为女性在生长、衰老过程中，年龄与月经病的关系颇为密切，月经随着机体发育情况而变化，《素问·上古天真论》有云：“二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七肾气平均，故真牙生而长极；四七筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”^{[10]3-4} 阐述了女性随着年龄增长，身体状况及月经产生的一系列变化。再者《素问病机气宜保命集·妇人胎产论》中云：“妇人童幼天癸未行之间，皆属少阴，天癸既行，皆属厥阴，天癸已绝，乃属太阴也。”^{[19]117} 可见月经产生的基本物质——天癸，随年龄变化而来源各异。从月经初潮到绝经这一过程，年龄不同，各个阶段月经的生理有所差异，其发病的原因与病机也各有侧重，故先生将月经病分为青春期、生育期、更年期三个阶段进行讨论。

（一）青春期

1. 青春期月经生理特点

从月经初潮至生殖器官逐渐发育成熟的时期称青春期。世界卫生组织（WHO）规定青春期为10~19岁，约为“二七”至“三七”之年。此阶段伴随第二性征的逐渐出现，各脏腑组织功能日趋成熟，尤以生殖器官成熟为突出表现，此时肾气渐盛，天癸在先天肾精与后天水谷精微的滋养下充盈而至，同时肝气冲和，脾胃健壮，冲任二脉盛通，月经来潮。

一般妇科书籍根据《内经》所云“二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下”，普遍提出月经初潮的年龄为14岁左右，但由于受遗传、地域、营养等因素的影响，月经初潮的年龄或提前或延后，提前者可11~12岁来经，甚则9~10岁；延后者可晚至16~17岁，甚则18岁之后。总体来看，随着现代生活条件的改善，文化水平的提高，月经初潮年龄趋于提前。

2. 青春期月经病病因病机

由青春期生理特点所决定，先生认为此阶段各脏腑刚刚由稚嫩趋向成熟，肾气尚不充盛，肝气初发，脾气脆弱，各脏腑功能尚未稳定，故部分女性不能很好地建立有规律的月经周期，某些月经病在这一阶段容易发生，如经来过早或过迟、经乱、月经稀发、经来复止等等。先生认为此阶段引起月经病的主要病因病机如下。

（1）主要病因

①先天禀赋不足

“人之始生，秉精血以成，借阴阳而赋命。父主阳施，犹天雨露；母主阴受，若地资生。男女媾精，胎孕乃成。”^[20]即所谓“人始生，先成精”。禀受于父母的先天之精，是构成胚胎发育的原始物质，人在出生离开母体后，先天之精主藏于肾脏，成为肾精的一部分，决定着每个人的体质、生理、发育。若先天禀赋不足，则不能满足人体正常的生长发育及生理活动，更易出现经来过迟、月经稀发、月经量少等。故先生认为青春期月经病最主要病因为先天禀赋不足。

②后天调摄失宜

青春期是青少年生长发育的关键时期，需要大量阴精支撑，由于需求量的急剧加大，常常会导致机体内阴精的相对不足，引发脏腑功能失调，继而影响正常月经的潮汛。同时，这一时期正是学习的紧张时期，若不注意则容易用脑过度，引发髓海不足，甚则引起肾虚，《内经》所云“肾生骨髓”、“髓海有余，则轻劲多力，自过其度；髓海不足，则脑转耳鸣，胫酸眩冒，目无所见，懈怠安卧”^{[14]78}，正是这个道理。此外，青春期性教育的缺失会导致部分女性过早妊娠，再经过非正规途径的流产、引产，进一步加重脏腑损伤，造成冲任失调，引起月经稀发、经乱、经来复止等月经病。

③饮食失节或偏嗜

青春期部分女性追求形体而过度节食，容易损伤脾胃，甚至出现厌食等严重后果，造成气血化生之源匮乏，脏腑失于濡养，则会导致气血亏虚，脏腑功能低下，从而引起月经病。青春期常有饮食偏嗜，如嗜辣贪凉，嗜食甜腻膏粱之味等，导致脏腑功能失调，阴阳偏盛偏衰，引发各种月经病。若过食生冷，损伤脾阳，导致寒湿内生，气血凝聚，可出现月经后期、痛经、经行泄泻等；若过食辛辣，阳明燥热，热邪内聚，灼伤津液或热扰胞宫，迫血妄行，可出现月经先期、月经色黯、经行便秘等；若过食膏粱厚味，则易生痰聚湿，蕴而化热，造成湿热困脾或形体肥胖，可出现月经量少、

经行乏力、经质黏稠等。

④忧思过度

先生认为青春期最常见的情志失调为忧思过度。此阶段学习压力偏大，容易思虑过度，或所思不遂，而脾在志为思，与心神有关，有“思出于心，而脾应之”之说。同时随着月经初潮来临，女性常有羞怯心理，若此时缺乏正常的生理卫生知识，无正确的心理引导，容易心情不畅，忧思郁结。此外，青春期女性心理处于复杂时期，心思敏感，易受外界影响，自我观念较强，容易犯错，抗挫折能力较差，导致情绪不稳定而易变，引发情志失常，抑郁失志，进而引起心脾功能失常，影响正常的经带生理，甚则经闭不行，即《素问·阴阳别论》所云“二阳之病发心脾，有不得隐曲，女子不月”^{[10]36}。

(2) 主要病机

①肾气未充，冲任不调

月经的产生以“肾气盛，天癸至”为前提，气由精化，髓由精生，先天禀赋不足或后天调摄失宜，皆会影响肾脏功能，如《医碥·健忘》云用脑过度引起肾虚：“脑者，髓之海，肾之精也。在下为肾，在上为脑，虚则皆虚，此证之为肾虚，信矣。”^[21]先生认为青春期月经病首见于肾气虚。一者肾气虚，固摄失司，会导致冲任溢泄失常，经血非时而下，造成经乱无期、月经量或多或少、室女崩漏等。二者气能生精摄精，肾气虚阴精亏虚或阴液滑脱，水火不济，引发相火妄动，甚至激起心、肝之火，火扰血室，迫血妄行，冲任不固，皆会造成月经先期、月经量多、室女崩漏等。三者肾气虚，温煦功能失常，导致阳虚寒凝胞宫，冲任闭阻，气血运行不利，造成痛经、经来复止，甚至闭经等。

②阳明乏源，心脾虚弱

《景岳全书·杂证谟·血证》曰：“故凡血枯经闭者，当求生血之源，源在胃也。”^{[22]352}脾胃健旺，气血旺盛，冲任充沛，则月经正常。又《妇人规·经脉之本》云：“故月经之本。所重在冲脉，所重在胃气，所重在心脾生化之源耳。”^{[23]26}可见脾、胃、心三脏功能失调会影响月经的正常潮汛。一者脾胃虚弱，气血生化乏源，冲任失养，血海空虚，易造成经来过迟、室女经来复止、经量过少等。二者脾虚运化水液失职或脾阳不运，导致痰湿内生，阻滞冲任，壅塞胞宫，易造成痛经、经行量少、经水闭止不行等。三者“心主身之血脉”“奉心化赤”，且《素问·评热病论》云：“胞脉者，属

心而络于胞中，心气不得下通，故月事不来也。”^{[10]134}可见若心生血及总司血液运行功能失调，会导致血府空虚或血运失常，造成月经后期、经量过少、月经色淡，甚至经闭等。

（二）生育期

1. 生育期月经生理特点

“三七肾气平均……四七筋骨坚，发长极，身体盛壮”，该年龄阶段是生育的最佳时期，到“五七”，开始出现“阳明脉衰，面始焦，发始堕”，女性生育能力开始逐渐减弱，生育质量逐渐降低，故一般认为女性最佳生育年龄阶段为“三七”至“五七”之间。随着现代生殖技术的发展以及国家二胎政策的开放，刺激了部分女性的生育欲望，高龄产妇司空见惯，总体生育期年龄延长。

正常生育期女子，经过青春期机体的发育成熟，月经周期已规律，经血能按时以下，除“并月”“居经”“避年”等特殊情况下，一般月经周期为28天，前后波动3~7天且规律者可视为正常。正常经期为3~7天，一般为4~5天。月经量的多少难以统计，一般以每月月经量约30~50ml为适中，超过80ml为月经过多。^{[3]15}一般以行经中期（第2~3天）血量较多，行经初期（第1天）与末期（第4~7天）经量较少。正常经血颜色一般为红色稍黯，在行经初期颜色较浅或略黯，中期经色红，末期色淡红或色黯。正常月经质地应不稀不稠，无血块，无异味。另外，月经前后及行经时无伴随而来的身体不适等症状。

2. 生育期月经病病因病机

生育期女性月经病发病率高于青春期与更年期女性。先生认为此阶段易于情志不遂为患，最易气血失调，甚则耗伤精血，肝肾失于濡养，除常见月经的质地、颜色、周期、经期、经量等病症外，还有该阶段特有的月经病，如流产后月经失调、宫内放置节育器后月经失调、服避孕药后月经失调等等。

（1）主要病因

①抑郁忿怒过极

《备急千金要方·妇人方》云：“女子嗜欲多于丈夫，感病倍于男子，加以慈恋、

爱憎、嫉妒、忧悲、染著坚牢，情不自抑，所以为病根深，疗之难瘥。”^{[13]16}此阶段为女性情绪受外界影响最多的时期，先生认为生育期女性七情内伤多以抑郁忿怒为主。

《妇人规·论难易》云：“妇人幽居多郁，常无所伸，阴性偏拗，每不可懈。”^{[23]22}女性素体多郁，且现代社会女性压力较大，生活中的各种因素，如工作负担过重，人际交往不顺，家庭琐事困扰，子女教育问题，夫妻感情不睦，赡养老人等等，皆会造成情绪不畅而影响到气血的和谐，冲任的通泰，各脏腑的气机协调。《素问·本病》云：“人或悲怒，气逆上而不下，即伤肝也。”^{[10]398}抑郁忿怒过极会影响肝的疏泄功能，导致气血失调，引起各种月经病变。

②过劳多产及哺乳过久

先生认为现代女性的熬夜、加班、出差等高强度工作，加之生活中还需承担家务，照顾子女、老人等，长期劳累，劳肾伤肝，引发月经异常。《诸病源候论·妇人产后诸候·产后乳无汁候》云：“既产则血水俱下，津液暴竭，经血不足。”^{[24]206}分娩时的用力汗出和产创出血，造成津液损耗，气血亏虚，而部分女性多次生产、流产、堕胎，或行剖宫术，或多次进行人工生殖辅助技术，导致肝肾亏虚，损伤子宫胞脉，引起月经紊乱，甚则瘀浊蕴结，癥瘕积聚，引起闭经。《圣济总录·妇人气血门·血气统论》云：“在上为乳饮，在下为月事。”^[25]女子乳汁，乃冲任气血所化，故哺乳时间过久，不能及时断乳，也会引起月经失调。

（2）主要病机

①肝失疏泄，气血失调

《格致余论·阳有余阴不足论》明确提出：“主闭藏者肾也，司疏泄者肝也。”^[26]肝气条达则疏泄有权，血行通畅，月经调顺；《血证论·脏腑病机论》又云：“肝属木，木气冲和条达，不致遏郁，则血脉得畅。”^{[27]6-7}木失条达，肝气不疏，气血不畅，会影响正常的月经。故先生认为此阶段肝的疏泄功能尤为重要。一者肝疏泄不及，肝气郁结，导致气滞血瘀，血行不畅，胞脉阻滞，造成经前乳房胀痛、痛经、经行身痛等。二者肝失疏泄，不能助脾运化，导致经期津液输布障碍，水湿宣泄不利，泛滥肌肤或痰湿内聚，造成经行浮肿、经行泄泻、闭经等。三者肝郁化火，导致热扰冲任，迫血妄行，而造成月经先期、经期延长、经量过多等。四者肝疏泄太过，导致肝气上逆，冲脉气盛，血随气上冲，造成经行吐衄、经期急躁易怒、失眠多梦等，或肝气横逆犯胃，造成经行呕吐等。

②肝肾偏虚，冲任损伤

肝藏血，每月所下经血皆耗肝中所藏之血，而《素问·上古天真论》云：“肾者主水，受五脏六腑之精而藏之。”^[10]⁴又《张氏医通·诸血门》云：“精不泄，归精于肝而化清血。”^[28]肝肾二脏与月经来潮密切相关。若肝肾亏虚，则月经失调。一者肝肾亏虚，精血不足，导致冲任二脉失于濡养，经血不能按时而下，造成月经后期、月经量少、崩漏甚至闭经等。二者精血同源，血为气之母，气为血之帅，肝肾亏虚，气血乏源，导致气虚血虚或气虚血瘀，可造成月经量少、经期过短、经色浅淡等。此外，胞脉损伤也会影响月经，其中以冲任二脉损伤为主，《医宗金鉴·妇科心法要诀·妇人不孕之故》有云：“……若为三因之邪伤其冲任之脉，则有月经不调、赤白带下、经漏、经崩等病生焉。”^[2]冲主经水，任主胞胎，调节阴经气血，皆与女子月经来潮有关，若冲任二脉损伤，气血不足或通行不利，则导致血不能下注胞宫，泻出为月经，造成月经失调。

（三）更年期

1. 更年期月经生理特点

从“六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白”女性衰老开始，至“七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也”月经闭止不行为止，这一阶段称为绝经前期，更年期女性月经病均发生在此阶段。自然绝经通常是指女性生命中最后一次月经后，停经达到1年以上者。^[3]¹⁴一般认为女性绝经年龄为49岁左右，由于受体质、社会、家庭、心理、生活习惯与健康状况等诸多因素的影响，绝经年龄迟早不一，以42~54岁之间较为集中。此阶段由于各脏腑功能衰退，肾气渐衰，天癸将竭，任脉虚，太冲脉衰，月经的色量、质地、周期等均会有所改变，直至闭经。此阶段月经生理性改变，一般不影响机体活动，属正常生理现象，大多女性能自我调节，平稳渡过。

2. 更年期月经病病因病机

大部分女性在更年期绝经前后，可伴随出现一系列症状和体征，如月经周期紊乱、烦躁易怒、眩晕耳鸣、潮热汗出、失眠多梦、头痛身痛、浮肿肥胖等，病情轻重不等，

症状二三交替出现，称为“经断前后诸证”，现代医学称为“更年期综合征”，又称“围绝经期综合征”，经期会加重症状，严重者影响生活，此为更年期常见月经病。此外，绝经前经乱，经断复行等月经病也较常见。

（1）主要病因

①情志失调

先生认为情志因素是更年期月经病的重要原因之一。此阶段由于女性生理机能的改变，且此年龄阶段家庭中开始面临子女成家立业，长辈的相继离世，孙辈的出生与照看以及中年婚姻危机等等，极易影响情绪。工作上，女性此阶段正值临退休年龄，压力相对较大。这些都增加了情志失调的几率。

②脏腑功能衰退

脏腑失调是月经病产生的机制之一，先生认为更年期脏腑功能衰退是月经病产生的另一重要原因。心主血脉失调，则生血无源；肝藏血失调，疏泄无度，则经血无以下注冲任；脾化生虚弱，气血无源，胞宫失养；肺主气无权，则气机逆乱，血不循经；肾衰则气血之根渐绝。更年期女性脏腑功能或多或少有所衰退，影响月经来潮。另外，各种疾病如高血压、高血脂、甲状腺功能亢进等，可间接对月经的产生、施泄产生影响。更年期女性部分体型肥胖，痰湿积聚妨碍冲任经脉通畅，阻塞子宫胞络，导致瘀浊黏连，甚则癥瘕积聚，影响月经。

（2）主要病机

①阳明脉衰，肝脾不调

先生认为女性到了更年期阶段，由于中间三十余年经、带、产、乳的消耗，自身气血已不足，而脾胃的逐渐虚弱，再加上肝气的不舒，则诸证易生。一者土虚木乘，肝脾不和，而致肝气乘脾或肝郁脾虚，则脾失统血，造成月经紊乱，或经行泄泻、食欲不振、经行腹痛、或经行情志异常等。二者肝脾不调，痰气郁结，而致气血运行不畅，瘀血阻滞，造成月经先后无定期、月经量少、闭经等，如《女科切要·调经门》云：“肥白妇人经闭而不能者，必是痰湿与脂膜壅塞之故。”^[29]三者脾胃虚弱，土虚水侮，导致水湿停聚，痰湿中生，阻碍血海胞宫，易造成经行腹痛、月经紊乱、闭经等。

②肾气渐衰，阴阳失衡

更年期相对其它年龄阶段而言，肾之功能衰退尤为明显。肾气渐衰，天癸将竭，冲任虚少，易致阴阳失调，而出现月经期、质、色、量的改变。一者肾阴不足，失于

滋养，阴虚不能制阳，导致虚热内生，则易造成经行眩晕、经行发热、月经量少等。二者肝肾同源，肾阴不足，水不涵木，亦导致肝阴亏虚，阴虚阳亢，则造成经行耳鸣、经行头痛、经行心烦等。三者肾阳不足，命门火衰，失于温煦，固摄无权或蒸化无力，水湿泛滥，造成经行泄泻、经行畏寒、或经行浮肿等。四者阴阳互根互用，阴损及阳，阳损及阴，故病程日久，可出现阴阳两虚，肾阴虚证与肾阳虚证则夹杂出现，更为复杂。

二、强调脏腑气血对月经作用

月经病的病位虽在胞宫，但与各脏腑关系密切，其中，先生认为以脾肾二脏与月经关系最为密切。气血的产生与各脏腑功能息息相关，脾肾二脏是气血化生的根源，其余脏腑对气血的生成与运行也有不同程度的影响，如《杂病源流犀烛》所云：“凡人之生，不外气血，而此气血，五脏皆兼有之。”^{[30]31}“血生于脾，统于心，藏于肝，宣布于肺，根于肾，灌溉一身，出入于脉。”^{[30]273}血是月经的主要物质成分，气是调摄月经的动力，气血可直接影响月经的产生。先生认为脏腑与气血之间的关系在月经病上尤为明显。

（一）月经失调 脾肾为先

1. 肾与月经

先生认为月经的产生与肾之生理机能密不可分。认为肾作为天癸之源，气血之根，从月经产生的根源上说明肾对月经的重要性；肾为冲任之本，与胞宫相系，若肾脏功能失调，则累及冲任二脉与胞宫对经血的调摄；肾与脑髓相通，可通过脑调控人体生理活动继而调控月经；肾为五脏阴阳之本，调节五脏功能运作，对维持月经有一定作用。

（1）肾为天癸之源，气血之根

天癸，是肾中精气充盈到一定程度时人体内产生的具有促进生长、发育及生殖的一种精微物质。天癸与女子月经息息相关。《医宗金鉴·妇科心法要诀·调经门》认为：“天癸，月经之源。”^[2]《血证论·胎气》亦云：“行经也，必天癸之水至于胞中，而后冲任之血应之，亦至胞中，于是月事乃下。”^{[27]74}说明天癸使冲任二脉充沛通达，

流通互资，血海溢满，月经应时来潮。

一般认为天癸来源于先天阴精，随肾的盛衰呈现消长盈亏。马蒔在《黄帝内经注证发微》中云：“天癸者，阴精也，盖肾属水，癸亦属水，由先天之气蓄极而生，故谓阴精为天癸也。”^[31]论证天癸来源于肾精。张景岳在《类经·藏象类》阐释道：“天癸者，言天一之阴气耳，气化为水，因名天癸……其在人身，是为元阴，亦曰元气，人之未生，则此气蕴于父母，是为先天之元气……第气之初生，真阴甚微，及其既盛，精血乃王，故女必二七，男必二八而后天癸至。天癸既至，在女子则月事以时下，在男子则精气溢泻，盖必阴气足而后精血化耳……肾气，即天癸也……女子天癸之数，七七而止……至是则冲任血少，阴气竭，故经水止绝而坤道不通也。天癸竭绝，故形体衰坏而不能有子矣。”^{[32]28}因此对女性来说，肾气初盛，天癸亦微；肾气既盛，天癸蓄极而泌，月事以时下；肾气渐衰，天癸乃竭，经水断绝。天癸是“肾主生殖”的精微物质与功能的统一体。^{[13]17-18}可见肾为天癸之源。

《冯氏锦囊秘录》有云：“气之根，肾中之真阳也；血之根，肾中之真阴也。于此根上补起，未有不发虚气血。”^[33]可见肾为气血之根，肾病则气血必然不足。《诸病源候论·虚劳病诸候·虚劳精血出候》云：“肾藏精，精者血之所成也。”^{[24]23}李中梓《病机沙篆》亦云：“血之源头在乎肾。”^[34]所以肾藏精，主骨生髓，精髓为化血之源，且精血能相互资生转化。肾精是化生血液的基本物质，血为气之母，气为血之帅，故气血久虚，当补肾益精以生气血。

（2）肾为冲任之本，与胞宫相系

冲任与女子月经关系密切，古代医家多将冲任二脉视为妇科月经病诊治的纲领。如《校注妇人良方·博济方论》中云：“妇人病有三十六种，皆由冲任劳损而致。”^[35]

《临证指南医案·调经》亦云：“凡女人水，诸络之血，必汇集血海而下。血海者，即冲脉也……不孕，经不调，冲脉病也。”^{[36]481}皆指出妇人月经病的产生与冲任二脉损伤有关。冲任二脉皆起于胞中，属奇经八脉。冲脉为“十二经之海”，涵蓄调节十二经气血，为“血海”，广聚脏腑之血，使胞宫盈满。任脉调节全身阴经气血，为“阴脉之海”，使所司之精、血、津液充沛。冲任通盛，则月事以时下，冲任虚衰，则经水断绝。

肾经与冲脉下行支相并，且与任脉交会于关元，冲任皆与肾间接相通，《邯郸遗稿》云“八脉俱属肾”^[37]；《续名医类案》引钱国宾云：“经本于肾，旺于冲任二脉。”

^[38]肾为元气之根，藏精化气，冲任二脉受先天肾气的资助。肾气旺盛，促使天癸的产生，才能使到任脉所司的精、血、津液旺盛充盈，又与冲脉相资，使冲脉得到肾精的充实，聚脏腑一定之气血，依时由满而溢于胞宫，使月事以时下。^[39]故肾为冲任之本。

胞宫司月经，如《血证论·男女同异论》有云：“女子胞中之血，每月换一次，除旧生新。”^{[27]5}且肾与胞宫相系，《难经·三十六难》指出肾在“女子以系胞”^[40]；《素问·奇病论》亦云“胞络者系于肾”。^{[10]176}胞宫为奇恒之腑，藏泻有时，以行为常，以通畅为顺，而肾司开阖，亦主子宫对月经的藏泻。

（3）肾与脑髓相通，为五脏阴阳之本

肾主骨生髓通脑，作强出伎巧，脑为元神之府，主宰人体的一切生命活动，月经的产生，亦离不开脑的调节。罗元恺提出“肾一天癸一冲任一子宫轴”的观点，肾为主导，由天癸调节，通过冲任二脉的通盛，由胞宫主司下并表现出来的妇科生理活动，并认为肾一天癸一冲任一子宫轴与当代医学的下丘脑—垂体—卵巢轴虽分属不同理论体系，但有殊途同归之妙，对调节女性生殖功能机理的方向是大致相同的。^[41]有研究表明助阳补肾中药对垂体的调节，可以影响黄体生及卵巢生成激素的灵敏性，通过生殖轴治疗下丘脑—垂体—卵巢的促黄体功能，达到改善黄体功能缺乏和调节女性内分泌功能，有助于月经的调理。^[42]

《医贯·玄元肤论·内经十二官论》云“五脏之真，惟肾为根”^[43]；《景岳全书·传忠录·命门余义》指出：“命门为精血之海……为元气之根……五脏之阴气非此不能滋，五脏之阳气非此不能发。”^{[22]30}肾为五脏阴阳之本，是五脏阴阳调节的中心。《灵枢·本神》云：“肾藏精，精舍志，肾气虚则厥，实则胀，五脏不安。”^{[14]26}肾不安，则五脏不安，五脏不安，则肝失条达，气血不畅；脾胃失健，血海亏虚；心肾不交，血脉不畅；肺失输布，胞宫失养，对月经的产生均有影响。

以上，肾对月经的产生具有主导作用，无论在月经的生理还是病理的发生过程中都具有其特殊意义，故《傅青主女科》有云“经本于肾”，“经水出诸肾”。^{[45]15}

2. 脾胃与月经

脾胃作为后天之本，先生认为经脾胃化生的水谷精微，不仅化生气血使冲任血海通盛，保证经血按时盈满，且不断资助先天肾之精气，保证天癸充足以行经水。

（1）脾胃为气血生化之源，充养冲任

脾胃为后天之本，气血生化之源，正如《医宗必读·肾为先天本脾为后天本论》所云：“一有此身，必资谷气，谷入于胃，洒陈于六腑而气至，和调于五脏而血生，而人资之以为生者也，故曰后天之本在脾。”^[46]《灵枢·玉版》亦云：“人之所受气者，谷也。谷之所注者，胃也。胃者，水谷气血之海也。”^{[14]119} 五脏六腑，四肢百骸，均赖脾胃运化而生的气血滋养。脾主统血，其气主升，具有统摄血液，固摄胞宫之权，与月经关系密切。《妇人规·经不调》云“经血为水谷之精气”^{[23]31}，脾胃健运，生化充足而气血自强；脾气健运，气有所摄而血循经行，则月经如期而至。

先生认为冲任与脾胃的关系密切。从经脉循行上看，冲任上行，与诸阳经相通，使冲脉之血得以温化，其下行，又渗于三阴，即肝、脾、肾之阴经，得其精血以为用。^[47]又《素问·痿论》有云：“阳明者，五脏六腑之海……冲脉者，经脉之海也，主渗灌溪谷，与阳明合于宗筋，阴阳宗筋之会，会于气街。”^{[10]169} 足阳明胃经与冲脉交会于气街，有“冲隶于阳明”之说。从气血相关上看，《临证指南医案·调经》载：“夫冲任血海，皆属阳明主司。”^{[36]484} “冲脉为月经之本也。然血气之化，由于水谷，水谷盛则血气亦盛，水谷衰则血气亦衰。”^{[36]490} 阳明为多气多血之腑，阳明气血旺盛与否对于冲任血海的盈亏、月经的溢损至关重要。所以胃的受纳腐熟功能强健，谷气旺盛，脾司运化之职如常，则气血充盛，充养冲任，气血下注胞宫而为月经。

（2）脾胃资先天之肾，滋养天癸

《景岳全书·杂证谟·脾胃》在论先后天之气关系时说：“脾胃为水谷之海，得后天之气也。何也？盖人之生，本乎精血之源，人之既生，由乎水谷之养，非精血无以立形体之基，非水谷无以成形体之壮。精血之司在命门，水谷之司在脾胃，故命门得先天之气，脾胃得后天之气也。是以水谷之海，本赖先天为之主，而精血之海又必赖后天为之资。故人之自生至老，凡先天之由不足者，但得后天培养之力，则补天之功亦可居其强半，此脾胃之气所关于人体者不小。”^{[22]214-215} 先天之精靠后天水谷之精的滋养，因此脾胃虚弱，运化无力，精血津液生化乏源，以致肾气不足，肾之真阴真阳亦不能得到滋养补充，随之渐衰。

《妇人规·经脉之本》中云：“天癸者，言后天之气，阴气足而月事通。”^{[23]25} 《医宗金鉴·妇科心法要诀·天癸月经之源》载：“先天天癸始父母，后天精血水谷生，女子二七天癸至，任通充盛月事行。”^{[2]418} 先生认为天癸虽源于肾，但是靠后天水谷之精逐渐滋养而产生的，天癸不得其充，自然经水乏源。天癸的衰退始自脾胃功能的虚

弱,逐渐由“阳明脉衰”至“三阳脉衰于上”,而后“任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通”。脾胃虚弱,肾之精气无以资,天癸逐渐衰竭,月事渐止。

3. 其它脏腑与月经

《血证论·阴阳水火气血论》载:“血生于心火而下藏于肝,气生于肾水而上主于肺,其间运上下者,脾也。”^{[27]3}除脾胃与肾外,其余脏腑对气血的产生也有不同程度的影响,各脏腑之间互相配合协调,气血的化生转运调和,机体各部功能正常,则月经可按时潮泄。故月经与五脏之中的心、肝、肺关系亦十分密切。

(1) 肝

先生认为肝的功能及生理特性所产生的气血与情志变化对女性月经影响较大。一方面肝的疏泄功能,对全身的气机起着疏通作用,血液的运行依赖于气机的调畅,气机条达,则气血运动有序,血海蓄溢有时,月经正常。肝主疏泄,不仅有助于血液的运行,且能使情志安和,《清代名医医案精华》中陈莲舫“多怒”医案云:“女科以肝为先天,善怒而多火。”^[48]肝在志为怒,过怒导致肝气上逆,血随气脱,或肝气郁结,气机不畅精血津液运行障碍,痰饮瘀血及癥瘕积聚内生,影响月经。肝属木,与风气相通,善行而主动,木旺于春,而春气上升,故肝主升主动,喜条达而恶抑郁,肝郁则易气滞血瘀,影响月经。同时,肝的升发之性,能鼓舞阳气,化生气血,使气充血旺。

另一方面肝主藏血,司血海。王冰注《素问·五脏生成篇》曰:“肝藏血,心行之,人动则血运于诸经,人静则血归于肝脏,何者,肝主血海故也。”^{[10]50}《本草述钩元》更言:“肝胆同为津液府,而肝木更为血脏。”^[49]肝主藏血,包括其贮藏血液和调节血量的生理功能。人体血量相对恒定,血液运动不息,而血之有余部分藏之于肝,月经来潮时,随着机体生理变化,下注血海,参与月经的生成。若肝贮藏之血不足以支撑月经来潮,肝会调节人体各部血液,参与月经,但通常会伴有各种不适症状。

因此,肝功能的正常是月经正常的必要条件,故有“女子以肝为先天”的说法。

(2) 心

心主血脉。心有生血的作用,即“奉心化赤”,心主血的功能依赖于心气,心属火,为阳脏而主阳气,心气充沛,心脏搏动有力,温煦并推动气血正常运行。《医林绳墨》云:“心主血,肝藏血,脾裹血,若崩中者,皆因心不能主……治宜……调摄

心气，使血有所归而心有所主。”^[50]认为崩中的原因之一是心气失去对血调摄作用。心主脉，心气使脉道通利，血流通畅，如此血液才能在经脉中流行不止，人体脏腑才能不断获得血液以完成各自功能。刘完素在《素问病机气宜保命集·带下论附》中指出：“如女子不月，先泻心火，血自下也。”^[64]另有《石室秘录》指出胞宫为“心肾接续之关”。^[80]心肾相交，水火相济才能维持心肾功能的正常。若心火亢盛，不能下降于肾，心肾不交，肾水不能制心火，则会热扰冲任血海，而致月经诸疾。

心藏神，心主神志。《素问·灵兰秘典论》云：“心者，君主之官也，神明出焉……故主明则下安，主不明则十二官危。”^{[10]40-41}《类经·疾病类》中云：“心为五脏六腑大主，而总统魂魄，兼赅意志。”^{[32]214}说明心主宰生命活动，主司意识情志等。《妇人大全良方·室女经闭成劳方论》篇中记载：“盖忧愁思虑则伤心，心伤则血逆竭，血逆竭则神色先散而月水先闭也。”^{[51]16}《医学正传·妇人科》亦指出：“或因七情伤心，心气停结，故血闭而不行，宜调心气，通心经，使血生而经自行矣。”^[44]可见思虑过度，导致心血暗耗，气血不足，精血不能蓄溢子宫，则月经不调。

因此，心血亏虚、心阳不温、心神郁闭、心气不畅、心火亢盛等，均可以影响月经的正常来潮。

（3）肺

先生认为，肺功能对月经的影响主要体现在气对血的运行及水液代谢上。一方面肺主气，司呼吸。人以气为本，气运行不息则人的生命活动延续。肺司呼吸功能受损，影响全身之气的生成和运行，继而影响血的运行。如《医述·女科原旨》所云：“血之行与不行，无不由于气，故血脱者当益气，血滞者当调气。气主于肺，其义可知。”^[52]血的运行与肺气密切相关。

另一方面肺主行水，宣发肃降。唐容川《血证论·经血》云：“女子之经，血中有水，故行经前后，均有水浆可验……故凡调血，先须调水，调水即是调气……故或调气中之水以滋血，或调血中之气而利水，是女子调经之法。”^{[27]62}说明若肺气行水功能失常，水津不能气化，则聚痰成湿，影响气血，致女子月经不调。

再者肺朝百脉，主治节。肺朝百脉，为百脉之宗，经脉的流通，必由于气，气主于肺。而全身血液都通过经脉流经于肺，经过肺的作用，将血液通过百脉输送至全身。肺主治节是指肺气具有治理调节全身气、血、水的作用，不仅调理全身气机，且能治理调节全身血液运行，保证月经条畅。

（二）以血为本 以气为用

先生认为女子以血为本，以气为用，气血调畅充盈则百病无生。《圣济总录·妇人血气门·血气统论》云：“血为荣，气为卫……内之五脏六腑，外之百骸九窍，莫不假此而致养。矧妇人纯阴，以血为本，以气为用。”^[25]气血对于女性生理至关重要，认为血充气顺为月经通调的基础，气血自身的虚实寒热可直接影响月经正常来潮。

1. 气血偏虚致月经病

基于气为血之帅的作用，先生认为气虚可直接引起诸多月经病症。首先气能生血，气虚则血虚，引起经血稀少等，如薛己《女科撮要》云：“一妇人素有头晕，不时而作，月经迟而少。余以为中气虚，不能上升而头晕，不能下化而经少，用补中益气汤而愈。”^[53]认为气虚导致月经量过少，需补气以生血调经。其次气能摄血，气虚则血失统摄，血不循脉，导致月经血量的异常，如《万氏妇人科·崩漏章》云：“妇人崩中之病，皆因中气虚，不能收敛其血，加以积热在里，迫血妄行，故令经血暴下而成崩中。崩久不止，遂成漏下。”^{[54]12}认为崩漏的原因是气虚不能敛血而致。再者气能行血，气虚则无力推动血行，产生瘀滞，引起经期各种疼痛，如《妇人规·经期腹痛》云：“凡妇人经行作痛，挟虚者多，全实者少。即如以可按、拒按，及经前、经后辨虚实，固其大法也。然有气血本虚，而血未得行者，亦每拒按。故于经前亦常有此证。此以气虚血滞，无力流通而然。”^{[23]82}认为气虚引起血瘀，从而导致痛经。

张景岳云：“凡女人血虚者，或迟或早，经多不调……盖血虚之候，或色淡，或涩少，或过期不至，或行后反痛，痛则喜暖、喜按，或经后则困惫难支，腰膝如折，或脉息则微弱弦涩，或饮食素少，或形色薄弱。”^{[23]58}血虚也可直接导致各种月经病症，调经先养血。傅山曾云：“妇人经水过多，行后复行，面色萎黄，身体倦怠，而困乏愈甚者，人以为血热有余之故，谁知是血虚而不归经乎！夫血旺始经多，血虚当经缩。今曰血虚而反经多，是何言与？殊不知血归于经，虽旺而经亦不多；血不归经，虽衰而经亦不少，世之人见经水过多，谓是血之旺也，此治之所以多错耳。倘经多果是血旺，自是健壮之体，须当一行即止，精力如常，何至一行后而再行，而困乏无力耶？惟经多是血之虚，故再行而不胜其困乏，血损精散，骨中髓空，所以不能色华于面也。治法宜大补血而引之归经，又安有行后复行之病哉。”^{[45]20-21}对经水过多一症，提出了“血虚而不归经”的观点，认为治当大补其血而引之归经。

故气血旺盛，是月经正常来潮的基础。

2. 气血失调致月经病

气行血，血载气，气郁滞则血癖，血凝滞则气不通。先生认为气血运行失调，冲任不通，经血不能按时满溢，则月经有碍。如《严氏济生方·妇人门·血气论治》云：“气之为病，男子妇人皆有之，惟妇人血气为患尤甚。盖人身血随气行，气一壅滞，则血与气并，或月事不调，心腹作痛；或月事将行，预先作痛；或月事已行，淋漓不断，心胀作痛。”^[55]认为气滞、气郁等气机不畅可导致经行作痛。《万病回春·调经》云：“经水过期而来，紫黑块者，气郁血滞也。”^[56]认为气滞血瘀，冲任受阻，瘀阻胞宫，则常月经后期且经色紫黑有血块。

另外，血寒、血热引起气血失调，影响月经，如《彤园妇人科·调经门》云：“脉数有力，紫黑成块，此热盛而兼化水也。”^[57]认为血热可导致经色紫黑成块。《仁斋直指·妇人论》有云：“自其血气不调，阴阳愆伏，过于阳则经脉前期而来，过于阴则经脉后期而至，盖血性得热则宜流，得寒则凝涩。阴气乘阳，内寒血涩，故其来乍少；阳气乘阴，血热流散，故其来乍多，过于不及，皆致病也。”^[58]认为血寒收引则经水过少，血热流散则经水过多。《金匱钩玄·妇人科·经水》云：“经水不及期，血热也……经候将来而作痛者，血实也……过期，紫黑色有块，血热也，必作痛……紫色成块者，乃是热也。”^[59]认为血热可导致月经不调，经色发黯，以及痛经。故气血失调，必影响经血的产生与运行，导致月经病的发生。

三、体质对月经影响

《灵枢·寿夭刚柔》云：“余闻人之生也，有刚有柔，有弱有强，有短有长，有阴有阳。”^{[14]19-20}每一个体都有不同的体质类型、生理特点。男女性别不同，生理特点有异，体质亦有别。体质现象是人类生命活动的一种重要表现形式，体质是人的先天禀赋和后天生活相融合而形成的身心整体素质，体现于人的形态、结构、功能、心性、伦理和适应环境的能力等方面。^[60]

体质是月经病产生的影响因素之一，月经随体质不同而表现各异，月经病的症状也因体质差别而不同。《沈氏女科辑要笺正·月事异常》有云：“二七经行，七七经止，言其常也。然禀赋不齐，行止皆无一定之候。柔弱者，年未不惑而先绝，壮实者，年

逾大衍而尚行，此随其人之体质而有异。故五十经行，未必皆病。”^{[61]29}明确指出女性月经与体质密切相关。

（一）月经病与体质的关系

先生认为体质是产生证候的内在基础，它决定着人体是否发病，并影响着疾病的证候类型，月经病作为妇科常见病，亦受体质的影响。

1. 体质影响月经病发病

先生认为体质因素与月经疾病关系十分密切，与月经病的发病相关，不同的体质偏颇导致发生的月经病各不相同。如《妇人规·血寒经迟》云：“凡血寒者，经必后期而至。然血何寒？亦惟阳气不足，则寒从内生，而生化失期，是即所谓寒也。”^{[23]54}可见素体偏于阳虚者，血不得温煦，无力推动，凝滞胞中，发病常见经行后期、经行量少、经行腹痛等；王孟英在《沈氏女科辑要笺正·月事不来》中按语：“阴虚者多火，经每先期。阴愈虚，行愈速，甚至旬日半月而一行。”^{[61]18}可见素体偏于阴虚者，阴虚火旺，热扰冲任，经血妄行，常见月经先期、月经量多等；《妇科玉尺》云：“经水过多不止，平时瘦弱，常发热者，由火旺也。”^{[4]15}可见素体偏于阳盛者，迫血旺行，冲任不固，月经疾病常见经行先期、经行量多、甚成崩中漏下等；《坤元是保·调经》云：“冲任虚衰，气不能固也。”^[62]素体气虚，气不固血，统摄无常，血不循经，常发病经行先期、经行量多或者经行延长日久等；《妇人规·肾虚经乱》又云：“凡欲念不遂，沉思积郁，心脾气结，致伤冲任之源，而肾气日消，轻则或早或迟，重则渐成枯闭。”^{[23]69}可见若素体抑郁多忧，偏于气郁者，损伤心脾，气血乏源，冲任不充，而耗伤肾气，则月经病多发经行过早、经行过晚、经期先后无定期，甚至闭经；《寿世保元·调经诸方》指出：“肥盛妇人，经水或二三个月一行者，痰盛而躯脂闭塞经脉。”^[63]另有《万氏妇人科·调经章》云：“脂痰凝塞者，盖妇女之身，内而肠胃开通，无所阻塞，外而经隧流利，无所碍滞，则血气和畅，经水应期。惟彼肥硕者，膏脂充满，元室之户不开，挟痰者痰涎壅滞，血海之波不流。故有过期而经始行，或数月而经一行。”^{[54]4}可见素体肥胖者多为痰湿体质，脂膏痰湿壅塞胞宫脉络，经络阻滞，冲任不通，湿痰流饮盘踞血海，临床发病常见月经量少，甚或闭经。

以上可知，月经病的发病与体质因素有着必然联系，临床在月经病辨证论治的整

个过程中，始终不应离开对患者体质状况的分析和把握。

2. 体质决定月经病证候类型

先生认为体质与月经病证候有密切关系。在临床工作中常遇到这样的现象：相同的体质，感受不同致病因素，则会表现出相同的疾病证候。如同为气虚体质，分别感受寒邪与热邪，虽病因不同，但由于气虚无力行血，瘀滞胞中，寒邪凝滞，加重瘀血生成；热邪灼血，久而化瘀，不通则痛，故临床月经病都会出现痛经、有血块等证候。相反，不同的体质，感受相同致病因素，由于人体阴阳气血盛衰的不同，邪随体化，可表现不同的月经病证候。如同样感受湿邪，阳盛体质从阳化热，表现在月经病上则有行经量多或经期延长、经色红、经质稠或有血块、小腹灼痛拒按、舌红、苔黄腻、脉滑数等湿热证候；阴盛体质则从阴化寒，月经病表现为小腹冷痛、得热痛减、行经量少、色黯有血块、肢体酸重、舌黯、苔白腻等寒湿证候。再如，同样遭受精神刺激，阴虚体质因气郁化火，内热加重，月经病表现为经期提前、月经量多、经色红、口干舌燥、五心烦热、舌红苔少、脉弦数等阴虚证候；而气滞体质则气机郁滞更甚，表现为月经延后、月经量少、经色黯有血块、小腹胀痛、暖气呃逆、舌红苔薄、脉弦、甚至出现闭经等气滞证候。

《灵枢·五变》篇曾以匠人砍柴来比喻这种关系，论述如下：

黄帝曰：一时遇风，同时得病，其病各异，愿闻其故。少俞曰：善乎哉问！请论以比匠人。匠人磨斧斤、砺刀削斲材木，木之阴阳尚有坚脆，坚者不入，脆者皮弛，至其交节，而缺斤斧焉。夫一木之中，坚脆不同，坚者则刚，脆者易伤，况其材木之不同，皮之厚薄，汁之多少，而各异耶？夫木之早花先生叶者，遇春霜烈风，则花落而叶萎；久曝大旱，则脆木薄皮者，枝条汁少而叶萎；久阴淫雨，则薄皮多汁者，皮溃而漉；卒风暴起，则刚脆之木，枝折机伤；秋霜疾风，则刚脆之木，根摇而叶落。凡此五者，各有所伤，况于人乎！

黄帝曰：以人应木奈何？少俞答曰：木之所伤也，皆伤其枝。枝之刚脆而坚，未成伤也。人之有常病也，亦因其骨节皮肤腠理之不坚固者，邪之所舍也，故常为病也。^{[14]94-95}

以上内容明确提出不同的证候表现是由于体质不同造成的。体质的差异性决定月经病对致病因素的易感性和发病类型的倾向性，从而影响月经病的证候类型。

（二）不同体质的月经病证候

先生以构成人体的基本物质，即“阴阳气血津液”作为体质分类的基础，将人群中的个体分为九种基本类型：阳虚质、阴虚质、气虚质、血虚质、阳盛质、气滞（郁）质、瘀血质、痰湿质和均衡质。除均衡质外，另外八种体质均可导致不同证候的月经病。各体质在月经病上临床表现如下。

1. 阳虚质

平素形寒喜暖，面色淡白，精神不振，性格多内向，脾肾常不足，易感寒湿阴邪为病。月经病表现为阳虚证候。如经期错后，量少，经色淡质稀，或色紫黯有血块；或经血非时而下，出血量多，淋漓不尽；带下量多，质稀；小腹冷痛或隐痛，得温痛减，畏寒肢冷；面色青白或㿔白或晦黯，或身面浮肿；疲倦乏力，精神不振；口不渴，头晕耳鸣，腰膝冷痛；小便清长，夜尿多，大便溏薄，或五更泄泻，下利清谷；舌淡胖有齿痕或舌黯，苔白滑，脉沉迟或沉紧或沉弱等。

2. 阴虚质

平素形体多消瘦，性情急躁，肝肾常不足，易感温热暑邪为病。月经病表现为阴虚证候。如月经提前，经期延长，量少，色红质稠；或月经周期紊乱，量多或少，经色鲜红；或颧赤唇红，口舌生疮，咽干口燥，皮肤瘙痒；五心烦热，夜寐不宁，潮热盗汗；或腰膝酸软，眩晕耳鸣，头痛；小便少，大便干，或胁痛眼涩，视物模糊；或干咳少痰，咽痛音哑；或饥不欲食，大便秘结；舌红或绛，苔少或花剥苔，脉细数等。

3. 气虚质

平素多易于疲惫，倦怠乏力，喜温怕冷，脾肺常虚弱，易感风寒等外邪为病。月经病表现为气虚证候。如月经提前，或经期延长，量多；或经间期出血，量少；或经血非时而下，量多如崩，或淋漓不断；色淡质稀，神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，隐痛；或带下量多，色白质黏；或喘息自汗，心悸怔忡，面色苍白；或纳少腹胀，小便清长，大便溏泻；或腰膝酸软，头晕耳鸣；舌淡红，苔薄白，脉缓弱或沉细等。

4. 血虚质

平素面色少华，形体多消瘦，性格多内向，心肝脾常虚弱，易伤于饮食劳倦。月经病表现为血虚证候。如经期错后，量少，或点滴即止，甚则闭经；色淡质稀，小腹胀痛喜按；面色淡白或萎黄无华，唇舌色淡；皮肤不润，甚则风疹团块；神疲肢倦，头痛头晕，目眩；心悸失眠，少寐多梦；或四肢麻木拘挛；舌淡，苔薄，脉细弱等。

5. 阳盛质

平素喜冷怕热，形体多壮实，性格多外向，心肝肺胃常偏亢，易感受温热火邪为病。月经病常表现为实热证候。如经期提前，或经期延长，量多，色鲜红或深红，质稠；或经血非时而下，量多如崩，或淋漓不断；心胸烦闷，面色红赤，头晕少寐；渴喜冷饮，大便燥结，小便黄；面部或肢体易生疮疖；或生斑疹，色红瘙痒，遇热尤甚；或带下色黄，有臭味；或头痛目赤，口舌生疮，口臭牙痛；舌红苔黄，脉数等。

6. 气滞（郁）质

平素性格抑郁或急躁，肝气常不疏，易伤于七情。月经病常表现为气滞证候。如经期错后或经行不畅，量少，经色黯红，有血块，小腹胀痛，甚则停经；或月经先后无定期，量或多或少；或经行发热，烦躁易怒，口苦咽干；或精神抑郁，时欲太息，胸胁、乳房胀痛；或头部胀痛，眩晕耳鸣；或胸闷不舒，失眠多梦；或暖气食少，肠鸣泄利；或咽中梗阻，如有异物；舌红，苔薄白或薄黄，脉弦或涩等。

7. 瘀血质

平素性格多执拗，中年人多见，易伤于七情或劳逸。月经病常表现为血瘀证候。如经行量多或经行涩少，色紫黑，质稠有块；小腹刺痛拒按，血块下后痛减，或平时小腹胀痛；或经闭，胞中有癥块，或崩漏；或面色晦滞，有色素沉着，心胸憋闷刺痛，口唇青紫；或经行发热，乍寒乍热；或头痛如锥刺，失眠健忘；或胁肋、肢体局部刺痛，固定不移；舌紫黯或有瘀点，脉涩或弦等。

8. 痰湿质

平素形体多肥胖，易伤于饮食，易感湿邪等为病。月经病常表现为痰湿证候。如经期错后，量少，甚则停经，色淡，质黏，嗜食肥甘，形体多肥胖；或经期头痛，头晕目眩，口中黏腻不爽；或心悸气短，脘闷恶心，纳呆腹胀，咳喘痰多；或面浮肢肿，小便不利，大便不爽；或头身重困，关节痛重，神疲体倦；或带下量多，色白质稠；舌淡胖，苔白腻，脉滑或濡等。

先生根据大量临证经验，认为在实际生活中，由于现代外部环境污染、饮食作息不规律、生活方式加快等，相对于单一体质，复合型体质的偏颇更为常见，使女性月经病辨证更为复杂。

第三部分 田代华教授月经病临证经验及用药分析

一、月经病基本治疗原则

《陈素庵妇科补解·调经门·调经总论》云：“女子二七而天癸至，月水之生，询非一朝一夕。盖积五千余日，而后血始充满，满则溢，其来有常，所谓以时下也。夫五千余日之内，襁褓乳食者数年，孩提抱哺者又数年，所受水谷之精气，以聚为阴血者无几。必至二七，然后肾脏内所受五脏六腑之精蓄积而通，积满而溢。任主胞胎，斯时则脉通（胞胎脉通故能合而有子）。冲为血海，斯时则脉盛（血海满故月事以时下也）。三旬一至，以象月盈则亏。”^{[64]5-6}指出女子月经并非一朝一夕产生，而是慢慢通过脾肾对气血阴精的集聚，再经冲任，下至胞宫，月经才能按时一至。先生认为，脾肾二脏作为先后天之根本，对月经的产生至关重要，而月经的化生、运行、施泄又始终离不开气血的作用，从月经初潮到绝经，气血始终贯穿整个过程，气血充沛调和，是月经正常来潮的物质基础，故先生调治月经病的基本原则为：补肾健脾，调理气血。

（一）补肾益精

王孟英在《沈氏女科辑要笺正·经水》按中说：“盖人身五脏，惟肾生最先，而肾足最迟，肾衰独早。”^[61]张景岳认为“经水不调，病多在肾”，赵献可亦主张“调经以滋水为主”。肾的盛衰维系整个人体，影响女性生理病理，肾阴阳失调，必然导致月经紊乱等病变，故先生临床调治月经病重点从肾辨治。

1. 月经病在肾的辨证

肾的盛衰影响天癸的至与竭，直接关系月经。肾气虚，则肾的气化封藏、摄纳功能减退。先生认为月经初潮阶段与更年期阶段的月经失调及经行合并症状，多与肾气虚密切相关，可出现月经初潮较迟；或月经先期，月经量多；或月经先后无定期，甚至闭经；或月经后期，量少，甚则点滴而净；色淡，经质稀。常伴有面色苍白，气短懒言，劳倦乏力，头晕耳鸣，小腹空坠隐痛，腰腿酸痛，大便溏薄，小便清长等症状。舌淡红，苔薄或苔少，脉多细弱或沉细或虚弱。

肾阴包括肾脏所藏之精，与肾阳互根互用，互相转化，是肾脏功能活动的物质基础。肾阴不足，冲任血虚、胞宫失养，或阴虚阳亢，虚热内生。可出现月经后期，月

经量少，闭经；或漏下，色紫红，经质黏稠；或发为经间期出血。常伴有腰膝酸软，小腹疼痛，两目干涩，头晕耳鸣，咽干口渴，五心烦热，失眠，头痛身痛，经行吐衄等症状。舌红，少苔，脉多沉细数。

肾阳虚，则肾的温煦、气化、施泄功能减退。命门火衰，寒从中生或气化失司，统摄无权，或水湿代谢失常。可出现月经量多；或崩漏则量多忽然不止，或量少淋漓不尽；月经后期，闭经；色淡黯，经质稀。常伴有畏寒肢冷，小腹冷痛，得热则舒；腰膝酸软，面色晦黯，精神萎靡，纳差，泄泻，浮肿，小便不利等症状。舌淡，苔薄白或白腻，脉多为沉细或沉缓。

2. 补肾用药

对于肾虚，先生一般以六味地黄丸为基础方，去熟地、泽泻，加杜仲、桑寄生。组成以山萸肉、怀山药、茯苓、丹皮、杜仲、桑寄生为主的补肾基础方，并随证加减药味。先生认为熟地性质黏腻，有碍消化，且在临床发现若药品炮制不当，患者易发生腹泻，故一般舍弃不用。而泽泻性寒，利水渗湿作用较强，不适用于平补肾气。

此方中，山萸肉即山茱萸的别名。《神农本草经》将其列为中品，认为其“久服轻身”。^{[65]30}山茱萸味酸、涩，能收敛止汗，固涩滑脱，为防止元气虚脱之要药，《医学衷中参西录》云：“味酸性温。大能收敛元气，振作精神，固涩滑脱。”^[66]本品性温而不燥，补而不峻，入肝、肾经，既能补益肝肾，又可助阳，《日华子本草》云其“暖腰膝，助水脏”^{[67]79}。先生利用其补益之中又具封藏之功，来达到补肝肾、固冲任的目的。

山药以河南怀庆府所产者品质最佳，故有“怀山药”之称。《神农本草经》属上品，云：“主伤中，补虚羸，除寒热邪气，补中益气力，长肌肉。久服耳目聪明、轻身、不饥、延年。”^{[65]7}现一般认为其味甘，性平，归脾、肺、肾经。具有补脾养胃，生津益肺，补肾涩精的功效。对于肾虚证，先生认为本品能补肾气，可补后天以充养先天，常用之治疗肾虚之诸证。若见脾虚泄泻，先生用炒山药，以增强健脾止泻之功。

茯苓性平，味甘、淡，归心、脾、肾经。甘能补，淡能渗，药性平和，既可驱邪，又能扶正。《日华子本草》云：“补五劳七伤，开心益志，止健忘，暖腰膝。”^{[67]71}丹皮苦、辛、微寒，归心、肝、肾经。《药性论》云：“治冷气，散诸痛，治女子经脉不通，血沥腰疼。”^[68]可以“通关腠血脉，排脓，通月经，消扑损瘀血，续筋骨”。^{[67]47}先生

常用此二味为补肾之佐使药。

杜仲味甘，性温。归肝、肾经。《本草纲目》曰：“杜仲色紫而润，味甘微辛，其气温平。甘温能补，微辛能润。故能入肝而补肾，子能令母实也。”^{[1]846}《玉楸药解》亦云：“荣筋壮骨，健膝强腰。杜仲去关节湿淫，治腰膝酸痛，腿足拘挛，益肝肾，养筋骨。”^[69]可见杜仲补肝肾、强筋骨，扶正固本之效甚强。桑寄生味苦、甘，性平。归肝、肾经。《本草求真》云：“桑寄生专入肝、肾。感桑精气而生，味苦而甘，性平和，不寒不热，号为补肾补血要剂。缘肾主骨发，主血。苦入肾，肾得补则筋骨有力，不致痿痹而酸痛矣。甘补血，血得补则发受其灌荫，而不枯脱落矣。故凡内而腰痛、筋骨笃疾、胎堕，外而金疮肌肤风湿，何一不藉此以为主治乎。”^{[70]23}本品长于补益肝肾、强壮筋骨，能养血而固冲任。先生常用此二味补益肝肾、填精养血，以治疗肝肾亏虚引起的月经诸证。

全方重在补肾填精，益气养血。山萸肉为平补阴阳之要药，收敛固涩，防止元气虚脱；怀山药补肾气，又能补脾肺之气，滋肺阴以生肾水，养脾阴助肾气，二者同用，共奏平补肾气之功；茯苓、丹皮入肾经，佐助山萸肉、怀山药以补益肾气，且茯苓助山药之健运，丹皮清泄虚热，制山萸肉之温涩，又辛行苦泄，有活血祛瘀之功，可治疗因血瘀引起的月经病；杜仲、桑寄生同用，助山萸肉、怀山药扶正固本，补肝肾强筋骨。

临床上偏于阴虚火旺者，先生常加知母、黄柏，取知柏地黄丸之滋阴泻火之效；阴虚甚者，用鳖甲、龟板大补肾阴，治疗阴虚阳亢，阴血不足；偏于阳虚者，加乌药、肉桂、肉苁蓉等以温中散寒、助阳止痛；阳虚甚者加附子、吴茱萸等以回阳救逆、益火消翳。

（二）健脾和胃

古代医家十分重视脾胃对月经的影响，并提倡从脾胃入手调理月经。如《兰室秘藏·妇人门》提出：“妇人脾胃久虚，或形羸气血俱衰，而致经行断绝不行。”^[71]《万氏妇人科·调经章》云：“脾胃损伤，饮食减少，气耗血枯而不行者，法当补其脾胃，养其气血，以待气充血生，经自行矣。”^{[54]9}《慎斋遗书》论治血崩难愈者有云：“必寻到脾胃之中，方无一失。”^[77]因为“万物从土而生，亦从土而归”，故健脾和胃，以滋气血生化之源，为先生治疗月经病常用之法。

1. 月经病在脾胃的辨证

脾主中气而统血，脾虚气弱，统摄无权，冲任不固，可出现月经先期，月经量多，经期延长，甚至崩漏；或出现月经后期，月经期过少；色淡，经质稀，无血块。常伴有面色苍白，或面色萎黄，神疲肢倦，少气懒言，心悸头晕，小腹坠胀等症状。舌淡，或边有齿痕，苔薄白，脉多细弱或沉弱。脾虚湿盛，可出现经行泄泻，经行水肿，色淡，质稀。常伴有纳少便溏，肢体重着乏力，脘腹痞闷，口淡无味等症状。舌淡红，苔白或微腻，脉缓或滑。胃失和降，可出现经行呕吐。常伴有食少满闷，嗳气，打嗝，反酸等症状。舌淡红，苔薄白，脉多为沉缓或沉弦。

2. 健脾和胃用药

先生常用香砂六君丸合四君子汤加减，组成以黄芪、党参、茯苓、炒白术、木香、砂仁、陈皮、甘草为主的基础方，并随证加减。

其中，黄芪性味甘温，归脾、肺经。具有健脾补中，升阳举陷，益卫固表的功效。《神农本草经百种录》云：“黄芪甘淡而温，得土之正味正性，故其功专补脾胃。味又微辛，故能驱脾胃中诸邪。”^[72]《得配本草》云：“黄芪味甘，微温，入手太阴经，兼入足太阴气分。助气补血。固腠理，益脾胃。”^[74]以其补气之功补气生血，扶助正气。先生利用其善入脾胃，为补中益气要药的特性，大补脾胃，以助经血化生有源。

党参性味甘平，主归脾肺二经，具有补脾肺气，补血生津之功效。《本草正义》言党参：“力能补脾养胃，润肺生津，健运中气，本与人参不甚相远，其尤可贵者，则健脾运而不燥，滋胃阴而不湿，润肺而不犯寒凉，养血而不偏滋腻，鼓舞清阳，振动中气，而无刚燥之弊。是禀坤土中正之气、柔顺之德，而无偏无患者。”^[75]以补脾肺之气为主要作用，生气以补血，常用于气虚不能生血，或血虚无以化气之气血两虚证。先生临床同用黄芪、党参，以健脾、益气、生血。

木香气香醒脾，味辛能行，味苦主泄，走三焦和胆经，如《本草纲目》云：“木香乃三焦气分之药，能升降诸气……中气不运，皆属于脾，故中焦气滞宜之者，脾胃喜芳香也。”^{[1]372}能通行脾胃，调畅气机，助血运行。砂仁气味芬芳，辛散温通，归脾、胃、肾经。其化湿醒脾，行气温中之效均佳，古人曰其“为醒脾调胃要药”，长于治疗湿阻中焦及脾胃气滞证，临床先生常用于脾胃寒湿气滞者。先生常同用木香、砂仁

以行气健脾，温胃散寒。陈皮味辛、苦，性温。归脾、肺经。《本草纲目》中言陈皮：“苦能泄能燥，辛能散，温能和。其治百病，总是取其理气燥湿之功。同补药则补，同泻药则泻，同升药则升，同降药则降。”^{[1]758}具有理气健脾，燥湿化痰之效。

白术味甘、苦，性温，归脾胃经。《本草求真》有云：“白术味苦而甘，既能燥湿实脾，复能缓脾生津。且其性最温，服则能以健食消谷，为脾脏补气第一要药也。”^{[70]9-10}本品既长于补气以复脾运，又能燥湿以除湿邪。先生临床用炒白术，以增强健脾益气作用，治疗脾气不足，运化失健引起的诸证。甘草味甘，性平，善入中焦，具有补益脾气之力。《本草正》云：“其味至甘，得中和之性，有调补之功，故毒药得之解其毒，刚药得之和其性，表药得之助其升，下药得之缓其速。助参芪成气虚之功，人所知也……祛邪热，坚筋骨，健脾胃，长肌肉，随气药入气，随血药入血，无往不可，故称国老。”^[76]因其作用缓和，故常作为辅助药。

全方重在益气健脾和胃，兼行气化滞燥湿。黄芪与党参相须为用，增强补脾益胃、补气生血之功；党参、茯苓、炒白术、甘草取四君子汤益气健脾之功效；与木香、砂仁、陈皮同用，醒脾开胃，行气化滞；陈皮、茯苓、木香、砂仁同用，增强行气化湿，健脾温胃之功；甘草与炒白术、黄芪等补脾益气药配伍用于脾气虚弱之证，且调和诸药。

偏于湿重者，加生薏米、苍术、藿香、石菖蒲以健脾利湿、醒神开窍；偏于痰湿蕴热者，加清半夏、橘红、瓜蒌以清热燥湿化痰；反酸烧心严重者，加煅瓦楞、海螵蛸以制酸；食少纳呆者，加鸡内金、焦三仙健脾开胃。

（三）调理气血

如前所述，先生强调气血对于女性月经的重要性。《妇人大全良方·产宝方序论》云：“大率治病，先论其所主。男子调其气，女子调其血。气血，人之神也，不可不谨调护。然妇人以血为基本，气血宣行，其神自清。”^{[51]9}所以调理气血，使之和畅，为女性之本，也是调经关键所在。

1. 月经病在气血的辨证

先生认为月经病气血发病有虚有实，虚证主要有气虚、血虚，实证以气滞、血瘀、血热为主。气虚失于固摄，腠理失固，防御降低，或失于温煦，可出现月经量多，甚

至崩漏；或经行外感；或出现经期延后，月经量少；色淡，质稀。常伴有自汗尿频，神疲乏力，腹胀便溏，浮肿等症状。舌淡红苔薄白，脉多见沉细或脉沉弱。血虚可出现月经后期，月经量少，甚至闭经；色淡，质稀。常伴有头晕眼花，面色萎黄或苍白，心悸少寐，手足麻木不温，神疲乏力等症状。舌淡苔薄白，脉多见细弱或沉细。

气滞则经行不畅，可出现月经后期，月经量少，或月经先后无定期；色黯红，有血块。常伴有小腹胀痛，乳房胀痛，胸胁脘腹胀痛，烦躁忧郁，呃逆呕吐，食少纳呆，泄泻或便秘，头痛眩晕，失眠等症状。舌黯红苔薄白，脉多为弦或涩。

临床血瘀可由多种原因导致。因虚致瘀，如气虚，血虚。可出现月经延期，月经量少，甚至闭经；色淡黯，有血块；常伴有头晕头痛，小腹坠痛，神疲乏力，少气懒言，面色萎黄或苍白，食欲不振，手足不温等症状。舌淡黯苔薄白，脉多沉涩或细涩。因实致瘀，如气滞、寒邪、湿邪。可出现月经量少，月经后期，闭经，色淡黯，有血块；或经期延长，月经量多，色黯，血块多。常伴有小腹刺痛拒按，或小腹冷痛，头胀痛或刺痛，胸胁胀痛刺痛，烦躁不安，手足发冷等症状。舌质黯有瘀点，苔薄白或白腻，脉多弦涩或沉涩或滑。因此，先生认为需分清月经病血瘀的原因，虚则益气、生血、祛瘀，实则理气、散寒、燥湿、祛瘀。

血热则致血分不安，可出现月经先期，月经量多，经期延长，崩漏，色红，质黏稠。常伴有心烦失眠，口渴，尿黄便秘，吐衄，神志失常等症状。舌红有瘀点，苔黄，脉多为数或滑数。

由于气血之间相互影响，对立统一，气血每多同病，且常虚实夹杂，如气滞血瘀，气虚血瘀，气血两虚等，临床症状更加复杂。

2. 调理气血用药

临床月经病多见以气滞、血瘀为主的气血失调证候，故先生常用柴胡疏肝散合四物汤加减，组成以香附、郁金、柴胡、当归、赤芍、丹参、红花、川芎、益母草为主的基础方，随证加减。其中，香附芳香辛行，味苦疏泄，归肝、脾、三焦经。善于疏理肝气，调经止痛，为妇科调经之要药。李时珍誉其为：“气病之总司，女科之主帅也……大凡病则气滞而馁，故香附于气分为君药。”^{[1]386}香附疏肝解郁，气血和顺，则月经自调，疼痛可除。郁金味辛能行能散，能活血，又能行气，长于治疗肝郁气滞之月经不调。归肝、胆、心经。且性寒清热，味苦能降泄，清心热，降肝火，以凉血降

气止血。故《本草备要》有云：“辛苦气寒，纯阳之品，其性轻扬上行……凉心热，散肝郁，下气破血。行滞气，亦不损正气；破瘀血。亦能生新血。”^[77]柴胡辛行苦泄，性善条达肝气，疏肝解郁，可治疗因肝失疏泄或肝郁血虚所致的月经失调，痛经等。

当归甘温质润，辛行温通。为活血行气之要药，《日华子本草》云：“治一切风，一切血，补一切劳；破恶血，养新血及主癥瘕。”^{[67]38}也是补血之圣药，《医学启源》云：“气温味甘，能和血补血，尾破血，身和血。”^[79]有补血调经，活血止痛之功。赤芍味苦，性微寒，归肝经，入肝经血分。《神农本草经》云其：“主邪气腹痛，除血痹，破坚积，寒热，疝瘕，止痛，利小便。”^{[65]24}有清热解郁，活血散瘀止痛之功。丹参性微寒而缓，对血热瘀滞之证尤为相宜，《本草便读》云其：“功同四物，能祛瘀以生新……善疗风而散结，性平和而走血……味甘苦以调经，不过专通于营分。丹参虽有参名，但补血之力不足，活血之力有余，为调理血分之首药。”^[73]既能祛瘀生新，又善活血调经，为妇科调经常用药。红花是先生治疗血瘀病证的常用药，辛散温通，归心、肝经。《本草汇言》云：“红花，破血行血，和血调血之药也。”^[78]为活血通经、祛瘀止痛之要药。川芎辛散温通，既能活血化瘀，又能行气止痛，功善“下调经水，中开郁结”，为妇科要药。益母草苦泄辛散，主入血分。善活血调经，祛瘀通经，为妇产科要药。

全方重在理气调血，活血以生新血，祛瘀而不伤正。柴胡与香附、郁金同用，理气为主，又入血分，行气解郁活血，使气行则血行，川芎与柴胡同用，开郁行气，活血止痛，川芎与当归同用，既能补血，又能行血，丹参、赤芍助当归活血散瘀，当归、红花相须为用，和血活血，益母草为妇科调经要药，祛瘀生新，行气行血。

偏于气血虚者，去柴胡、香附、郁金，加黄芪、党参、炒白术等以益气生血；气滞重者，加川楝子、枳壳、川朴等以疏肝行气，活血祛瘀；血瘀重者，加桃仁、莪术、三棱等破血祛瘀；偏于血热者，加丹皮、生地、紫草、焦栀子等清热凉血，或肝郁火旺者，加龙胆草清肝泻火；癥瘕痞块，乳房胀痛刺痛者，加夏枯草、山慈菇等散结止痛；疼痛甚者，加白芷、元胡等行气止痛。

二、月经病体质及治疗

《傅青主女科·调经·经水先期》中有：“女科调经尤难，盖经调则无病，不调则百病丛生。治法宜详察其病原，细审其所以不调之故，然后用药，始能见效。”^{[45]14}

先生认为体质作为影响月经的主要病因之一，临证时务必要详细审查患者的体质禀赋，以期有针对性地治疗。

（一）常见月经病体质及治疗

《景岳全书·杂证谟·血证》云：“人有阴阳，即为血气，阳主气，故气全则神旺；阴主血，故血盛则形强；人生所赖惟斯而已。”^{[24] 351}先生认为，气与血都由人体之精所化，阴阳互根互用，女子以血为本，以气为用，而六淫之中女性易感寒、热、湿之邪，均能与气血交搏，阻碍气运血行，故临床月经病多见于以气血偏颇为主的复合型体质，临床常见类型如下。

1. 气血两虚质

先生认为此型多见于先天体弱或后天损伤失养者。由于脏腑功能不足，引起人体气不足或血不足，加之持续耗损而补充不及，则最终导致气血两虚的体质状态。此类体质者平素易于疲惫，倦怠乏力，面色少华，形体多消瘦，性格多内向，喜温怕冷，易伤于饮食劳倦及外感，脏腑常虚弱，以脾肾为主。月经病多见经来过迟，量少，甚则闭经；或漏下；色淡质稀。常伴有神疲加重，气短懒言，喜卧；小腹空坠隐痛，喜温喜按；或心悸怔忡，少寐多梦；或气短、出虚汗；面色苍白，唇舌色淡；或四肢麻木拘挛，手足不温；或纳少便少、难下；或腰膝酸软，头晕头痛；舌淡，苔薄，脉沉弱或细弱等。

先生以气血双补为治疗原则，主用黄芪、党参、茯苓、炒白术健脾补气生血，山萸肉、怀山药补肾健脾，当归、丹参、赤芍、益母草补血活血行血，并随证加减。若头痛腹痛重者，加元胡、白芷等行气和血止痛；若头晕目眩，乏力重甚则漏下者，去党参，加人参，熟地、肉苁蓉等大补元气，补肾益精；若食少纳呆重者，加鸡内金、焦三仙等健脾开胃；若心悸怔忡、寐不安重者，加麦冬、五味子、柏子仁等养心安神；若气短汗出重者，加五味子、防风、麻黄根、浮小麦等补肺固表敛汗；若手足肢冷重者，加桂枝、肉桂、肉苁蓉等温通经脉，助阳化气等等。

2. 气虚血瘀质

气为血之帅，气行血亦行，气虚血亦滞，最终导致气虚血瘀的体质状态。此类体

质者，平素体弱多病，易于疲惫，易伤于七情，脾肺常虚弱。月经病多见月经提前，经行量多，经期延长，色淡黯；或经间期出血，量少色黯；或月经延后，量少，色黯，有血块甚至闭经。常伴有神疲肢倦，腰膝酸痛；小腹刺痛，得热则舒；面色萎黄，纳少腹胀；失眠健忘，头晕头痛；舌淡黯或有瘀点，苔薄白，脉弦弱或细涩等。

先生以补气活血为治疗原则，主用黄芪、党参、茯苓、炒白术健脾补气行血，当归、丹参、赤芍、红花补血活血，并随证加减。若情志失调重者，加柴胡、香附、郁金等疏肝解郁，行气活血；若腹痛头痛重者，加川芎、元胡、白芷等行气散瘀止痛；若食少腹胀重者，加木香、砂仁等醒脾开胃理气；若失眠健忘重者，加远志、茯神、龙眼肉等补血养心安神；若腰膝酸痛严重者，加杜仲、桑寄生等补肾健骨，强壮腰膝；若大便无力，质不干燥者，加火麻仁、肉苁蓉等润肠通便等等。

3. 气滞血瘀质

由于此类患者，性格抑郁或急躁，导致肝气郁滞，气滞血亦滞，滞甚则成瘀，日久导致气滞血瘀体质状态形成。月经病多见经期错后或经行不畅，量少，甚则停经；经色黯红，质稠有血块。常伴有小腹胀痛、刺痛，拒按，血块下后痛减；经行发热，烦躁易怒，口苦咽干；精神抑郁，时欲太息；胸胁、乳房、头部胀痛；面色、口唇晦黯，眩晕耳鸣；胸闷不舒，失眠多梦；暖气食少，肠鸣泄利舌红黯或有瘀点，苔薄白或薄黄，脉弦或涩等。

先生以理气活血为治疗原则，主用柴胡、香附、郁金疏肝行气，当归、丹参、赤芍、红花、川芎活血散瘀，并随证加减。若胸胁胀痛甚者，加川朴、川楝子等疏肝行气；若腹胀便秘甚者，加枳实，大腹皮等下气散结；若烦躁易怒甚者，加丹皮、焦栀子等清肝泻火；若暖气食少甚者，加木香、陈皮等行气健脾；若腹痛拒按甚者，加桃仁、元胡等活血散瘀止痛等等。

4. 气滞痰湿质

此类患者形体多肥胖，易感湿邪为病，性格急躁，易伤于七情及饮食。肝脾常不和，脾虚湿盛，肝失疏泄，聚湿成痰，日久则成气滞痰湿质体质。月经病多见经来过迟或经行不畅，量少，甚则停经；色淡黯，质黏，有血块。常伴有小腹胀痛，头痛眩晕；经行发热，烦躁易怒；时欲太息，胸闷恶心；纳呆腹胀，大便黏滞；咽中梗阻，

如有异物；头身困重，神疲体倦；口中黏腻不爽，咳唾痰多；舌淡胖或舌红黯，苔白腻或黄腻，脉弦滑等。

先生以理气化湿为治疗原则，主用柴胡、香附、郁金疏肝行气，茯苓、苍术、清半夏、生薏米祛湿化痰，并随证加减。若烦躁易怒严重者，加丹皮、焦栀子等清肝泻火；若咳唾痰多重者，加白芥子、橘红等化痰止咳；若胸闷恶心重者，加瓜蒌、薤白宽胸散结；若头重如裹甚者，加石菖蒲、薄荷等醒神开窍；若咽喉不适重者，加川朴、桔梗等利咽散结等等。

5. 血瘀痰湿质

此类患者以中年女性多见，性情执拗易怒，形体多肥胖，平素嗜食肥甘厚味，易伤七情或饮食，易感湿邪等为病，肝脾肾三脏常功能失调。月经病多见经来过迟，经行涩少，色紫黑，质稠有血块；或月经先后无定期，月经量少，色黯，质黏有血块；或崩漏，色黯；甚则闭经。常伴有小腹刺痛拒按，血块下后痛减；或头痛头晕，目眩耳鸣；或面色晦黯，心胸憋闷刺痛，口唇紫黯；或经行发热，烦躁失眠；或脘闷恶心，纳呆腹胀，口黏痰多；或小便不利，大便黏滞或难下；或头身重困，关节肿痛；舌紫黯或有瘀点，苔腻，脉弦涩或弦滑等。

先生以活血化瘀祛痰为治疗原则，主用当归、丹参、赤芍、红花、川芎、益母草活血化瘀，苍术、生薏米、清半夏、瓜蒌祛湿化痰，三棱、莪术破血化瘀，并随证加减。若胸闷恶心痰多者，加竹茹，胆南星、薤白等宽胸散结，化痰祛瘀；若烦热失眠重者，加生地、丹皮、焦栀子等清热凉血活血；若癥瘕积聚者，加桃仁、夏枯草等祛瘀散结；若关节肿痛重者，加鸡血藤、威灵仙等活血通络止痛等等。

以上五种复合体质为先生在临床中常见的月经病发病体质类型，由于体质具有可变性，不仅受年龄影响而改变，且受外界因素不断干扰而变化，两种变化相互影响，同时存在，使得临床月经病体质情况更加复杂。

（二）各年龄阶段体质及治疗

如前所述，各年龄阶段月经的生理，月经病病因病机各有侧重，各阶段体质类型也各有差异，先生在临床上的治疗随之改变。

1. 青春期

先生认为青春期月经病多是由于脾肾不足，气血亏虚引起。临床上青春期月经病多与气血偏虚有关，体质类型常以气虚质、血虚质、气血两虚质为主。临床多见经来过迟，经量或多或少，或月经先后无定期，或痛经，或崩漏等，经色常红或淡，无血块或少量小血块，常伴虚证症状。

青春期调经以补肾健脾，益气养血为主。先生治疗常用归脾汤合六味地黄丸加减，组成以黄芪、党参、炒白术、当归、丹参、赤白芍、益母草、山萸肉、怀山药、茯苓、甘草为主的处方，随证加减。其中黄芪、党参、茯苓、炒白术健脾益气生血，山萸肉、怀山药平补肾气，当归、丹参、赤白芍、益母草补血活血调经，共奏益气养血调经之功。若因饮食不当，导致痰湿内生者，兼以祛痰湿，加苍术、生薏米、清半夏等燥湿化痰药；若偏于肾虚严重，腰膝酸软，头晕乏力者，着重补肾填精，加杜仲、桑寄生、枸杞子等补虚益精药；若偏于脾胃虚弱，食少不化，腹胀暖气者，着重健脾和胃，加陈皮、砂仁、鸡内金、焦三仙等健脾行气，开胃消食之药；若因情志抑郁不畅，导致肝气不疏者，兼以疏肝理气，加柴胡、香附、郁金等疏肝解郁药等等。

青春期月经病多由肾气初盛，脏腑娇弱的自身生理原因引起，故先生在临床上，用药剂量相对于成人酌情减少。

2. 生育期

先生认为生育期女性月经病气滞多见，部分因过劳多产，导致肾虚气血偏亏引起。故临床上生育期月经病多与气滞有关，体质类型以气滞（郁）质、气滞血瘀质、气滞痰湿质等为主。临床多见月经过迟，或闭经，或经间期出血，或月经先后无定期，月经量或多或少等，经色多黯红或淡黯，常有血块，常伴实证症状。

生育期调经当以理气活血，养血调经为主。常用柴胡疏肝散或逍遥散加减，组成以当归、赤芍、丹参、红花、川芎、柴胡、香附、茯苓、炒白术、甘草为主的处方，随证加减。其中，柴胡、香附疏肝理气，当归、赤芍、丹参、红花养血活血，川芎行气活血，佐以茯苓、炒白术健脾，使运化有权，气血有源，甘草调和诸药，重在疏肝解郁，理气活血。若偏于肾虚，腰痛腰酸者，加山萸肉、怀山药、杜仲、桑寄生等补益肝肾之药；若肝郁化火，血热妄行，烦躁易怒者，加丹皮、焦栀子、生地等清热凉

血药；若肝经湿热，口苦黏腻者，加龙胆草、黄芩、黄柏等清热燥湿泻火药；若肝脾不调，食少腹胀者，加陈皮、木香、砂仁等行气健脾开胃药；若气滞甚，胁肋胀满，腹胀不通者，加川楝子、川朴、枳实等行气除满药等等。

另外，先生疏肝解郁不独用药物来治疗，还常用言语来劝解开导慰藉病人，规劝病人适当活动，放松心情，赢得病人信任，有利于疾病缓解病情。

3. 更年期

先生认为更年期女性月经病多由肝肾阴虚、气滞血瘀引起，部分由它病引起。临床上更年期女性月经病多有瘀血症状，体质类型以气滞血瘀质、血瘀痰湿质、阴虚血瘀质等为主。临床多见经断前后诸证，月经量忽多忽少，或月经延期，或闭经等，经色多紫黯或黯淡，有血块质黏稠，常伴虚实夹杂症状。

更年期调经多以补肾疏肝，活血散瘀为主，兼调理脾胃。常用丹栀逍遥散合六味地黄丸加减，组成以山萸肉、怀山药、桑寄生、丹皮、杜仲、枸杞子、当归、赤芍、丹参、红花、柴胡、香附为主的处方，随证加减。其中，山萸肉、怀山药、杜仲、桑寄生、枸杞子补肾滋阴，柴胡、香附疏肝理气，丹皮、赤芍、丹参清热活血祛瘀，当归、红花活血化瘀，全方重在滋阴补肾，活血散瘀。若偏于阴虚火旺，手足心热，潮热盗汗者，加知母、黄柏等滋阴降火药，甚者加鳖甲、龟板以养阴清热，补肾益精；若瘀而化火，经行衄血者，加生地、紫草、侧柏叶等凉血止血药；若痰瘀互结，癥瘕积聚者，加夏枯草、清半夏、桃仁、三棱、莪术等化痰祛瘀散结药；若阴虚胃热，暖气吞酸者，加黄芩、黄精、煅瓦楞等以清热滋阴制酸药；若患有高血压者，加天麻、钩藤、夏枯草等平肝熄风药物等等。

另外，先生认为更年期女性绝经前后诸证，是由于人体正常衰退引起，除正常健脾补肾外，主要调理其症状，以不影响绝经期前后女性正常生活为要旨。而由于其它疾病引起的月经病，当先治它病，再调月经。

三、月经病用药规律数据分析

先生擅治月经病，积累了丰富的临证经验，通过收集、整理其历年门诊月经病病历，及跟师随诊、实时采集、整理月经病病历，并对所收集病历中的处方用药进行数据挖掘分析，以期对先生治疗月经病用药规律进行阐明和总结，便于直接指导临床实

践。

（一）资料与方法

1. 病历来源及筛选

（1）病历来源

本次研究的病历以 2017 年 11 月～2019 年 1 月就诊于山东中医药大学中鲁医院门诊及宏济堂中医诊所的月经病病历为主，以 2017 年 11 月之前保存的月经病病历为辅。

（2）病历筛选

①纳入标准

月经病的诊断标准参照《中医妇科学》（新世纪第二版）。

A. 符合上述月经病的诊断标准。

B. 由田代华教授门诊遣方治疗者。

上述 2 项需同时具备。

②排除标准

A. 妊娠期、产褥期及特殊月经生理现象（并月、避年、激经等）。

B. 因生殖器官器质性变（子宫腺肌病、子宫内膜异位症、子宫肌瘤等）及垂体肿瘤引起的月经异常患者。

C. 合并有严重的心血管、肝、肾和造血系统等原发性出血疾病患者等。

依据上方的标准，共筛选出病历 192 人，共计 422 首处方录入。

2. 数据处理及挖掘方法

（1）数据预处理

由于中药存在异名现象，同时先生常在处方中对药物进行简写或将常用药对进行复合书写，因此，在录入前对中药名称进行统一规范化处理（详见附表 1）。

（2）分析软件

“中医传承辅助平台（V2.5）”软件由中国中医科学院中药研究所与中国科学院自动化研究所联合开发。^{[5]10}

（3）数据分析

选择“中医传承辅助平台（V2.5）”软件中“数据分析”板块中的“方剂分析”功能，运用“组方分析”板块分别进行频次统计、组方规律、新方分析。

①频次统计分析

在“组方分析”板块对录入处方中的中药进行频次统计，并将结果按照从大到小的顺序导出。

②组方规律分析

在“组方规律”板块中，通过调整支持度个数和置信度，实现对药物高频组合及相关性的统计与挖掘，并对核心药物关系进行网络展示。

A. 支持度个数：指药物组合在所选处方中出现的频次（本参数 $\leq$ 处方总数）支持度个数=方剂数 $\times$ 支持度，根据实际数据量调节。^{[5]45}

B. 置信度：“一>”左边为A，右边为B。当A药物出现，B药物出现的概率（A出现后，本参数越接近1，B出现的概率越高）。^{[5]45}

③新方分析

在“组方规律”板块中，通过设置相关度和惩罚度实现对药物低频次高相关组合及相关性的统计与挖掘，并对其进行网络展示，显示核心药物组合及由此构成的新处方。^{[5]47-49}

根据设计者对系统的测试分析结果，相关度为“8”，惩罚度为“2”，是比较理想的参数，能得到可靠满意的结果。

（二）结果

1. 频次统计

通过药物频次统计，得出先生422首处方中所用中药的频次共7460次，共涉及中药201味，将用药频次进行降次排序（详见附表2）后，其中频次 ≥ 100 的药物有18味，用药频次共计4449次，见表1。除甘草外，使用频次最多的前10味中药，频次共计2929次，见图1，频次均 ≥ 195 。

表 1 月经病主要中药频次表（频次≥100）

序号	中药名称	频次	序号	中药名称	频次
1	甘草	426	10	香附	198
2	当归	416	11	党参	195
3	丹参	376	12	川芎	194
4	赤芍	371	13	益母草	180
5	茯苓	344	14	炒白术	178
6	红花	300	15	牡丹皮	161
7	黄芪	269	16	柴胡	136
8	山茱萸	234	17	杜仲	127
9	山药	226	18	炒枣仁	126

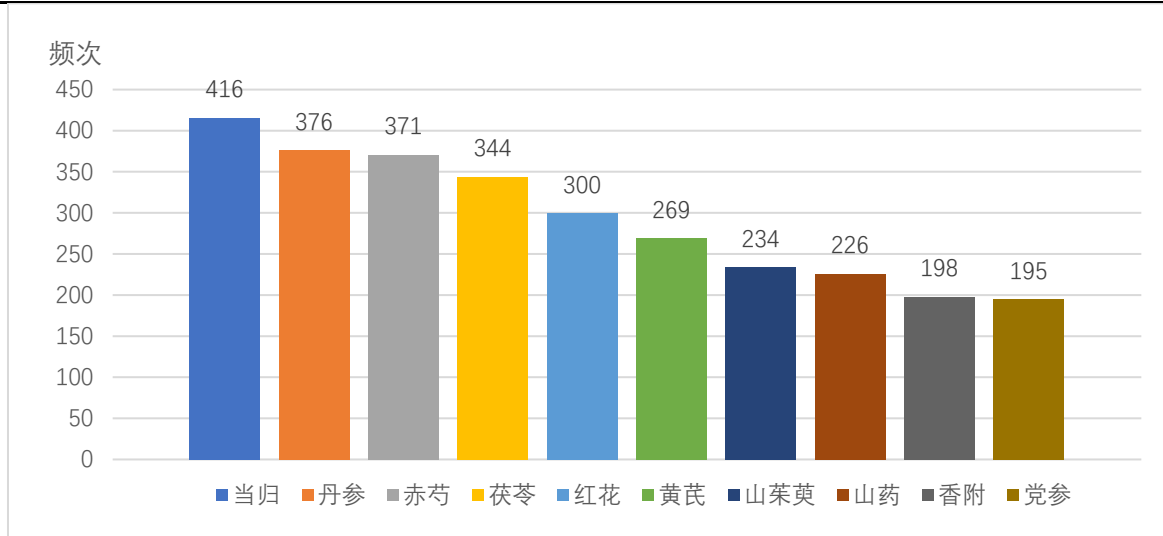


图 1 月经病前 10 味中药频次图（除甘草外）

参照《中药学》（新世纪第二版）相关药物分类，共涉及 41 类药物，将使用频次 ≥100 的 18 味中药按门类（详见附表 3）进行统计，共 11 类药物，见图 2。

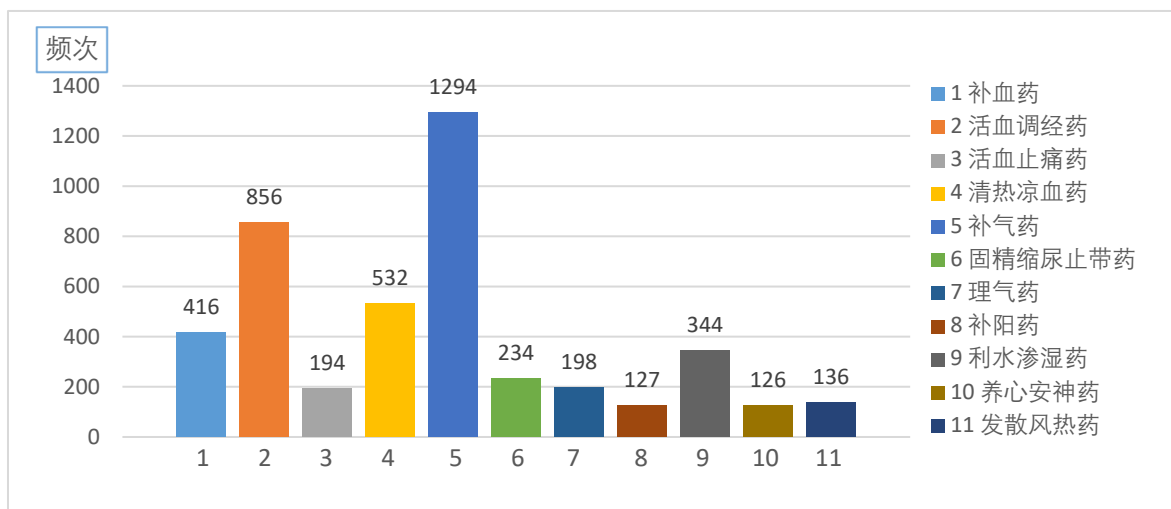


图 2 月经病主要中药门类频次图（频次≥100）

2. 组方规律

在置信度为 0.90,支持度个数分别为 84(支持度为 20%)、211(支持度为 50%)、295（支持度为 70%）的情况下，对先生月经病组方用药规律进行分析，结果分别以网络展示图呈现，见图 3、图 4、图 5。

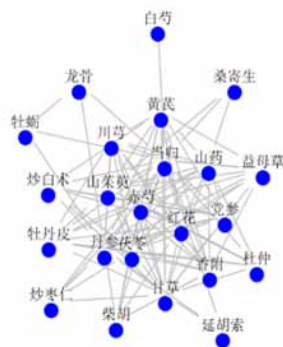


图 3 支持度个数 84



图 4 支持度个数 211



图 5 支持度个数 295

在支持度个数为 211，置信度 0.90 的情况下，得出先生月经病最常用药物组合模式 64 条，并按频次进行降次排序（见附表 4），再对所得用药模式进行关联规则分析，得出 125 条关联规则（见附表 5）。

3. 新方分析

在相关度为 8、惩罚度为 2 的情况下，利用软件自动进行复杂系统熵聚类核心组合，得到由 3~4 味药物构成的核心药物组合 8 组，见表 2，进一步基于熵层次聚类形成新处方 8 个，见表 3。

表 2 复杂系统熵聚类核心药物组合

序列号	核心组合	序列号	核心组合
1	木香_陈皮_焦麦芽	9	陈皮_砂仁_姜半夏
2	防风_白芷_前胡	10	菊花_白芷_羌活
3	连翘_金银花_板蓝根	11	生地黄_金银花_蒲公英
4	全蝎_琥珀_藁本	12	琥珀_藁本_姜黄
5	黄芩_茯苓_杜仲	13	山药_山茱萸_桃仁_茯苓
6	胆南星_橘红_芥子	14	杏仁_橘红_桔梗_前胡
7	胆南星_芥子_槐角	15	煅瓦楞子_炒山药_槐角
8	山药_山茱萸_桃仁_枸杞子	16	山药_山茱萸_茯苓_杜仲

表 3 熵层次聚类新处方

序列号	新方组合
1	木香_陈皮_焦麦芽_砂仁_姜半夏
2	防风_白芷_前胡_菊花_羌活
3	连翘_金银花_板蓝根_生地黄_蒲公英
4	全蝎_琥珀_藁本_姜黄
5	黄芩_茯苓_杜仲_山药_山茱萸_桃仁
6	胆南星_橘红_芥子_杏仁_桔梗_前胡
7	胆南星_芥子_槐角_煅瓦楞子_炒山药
8	山药_山茱萸_桃仁_枸杞子_茯苓_杜仲

（三）讨论

1. 频次统计结果讨论

通过频次统计分析，由附表 2 可看出先生治疗月经病用药之广泛。临床月经病错综复杂，发病时身体及心理各种不适，或由于行经气血虚弱，外邪乘机侵袭，诱发其他疾病；或病时行经，伴随行经不畅等诸多症状，因此先生治疗月经病用药虽广，但常用药物多为益气活血，调经止痛之药。结合表 1、图 1 高频用药统计分析发现多为具有补气、理气、养血、活血、补血等具有调理气血功效的药物，用药频次占总频次的 59.6%，与先生治疗月经病强调理气血重要性的原则相符。

在频次 ≥ 100 的 18 味药物中，当归、丹参、红花、赤芍、川芎、香附、益母草等旨在养血行血，活血散瘀；黄芪、党参、当归、茯苓、炒白术、柴胡、甘草等为补中益气汤加减，可健脾补虚，补中益气；山茱萸、山药、杜仲等补肾固精益气。再与附表 3、图 2 中药类别频次分析相结合，以补血药、补气药、活血调经药为主，气血同调。以清热凉血药、固精缩尿药、理气药、利水渗湿药为辅，健脾补肾以濡养气血，凉血解郁、行气散瘀使血运通畅，行而不滞。符合先生健脾补肾，调理气血的学术思想及治疗基本原则。

2. 组方规律结果讨论

从图 3、图 4、图 5 可看出, 在支持度为 20%的情况下, 涉及四物汤、补中益气汤、柴胡疏肝散、归脾汤、四君子汤、当归补血汤、六味地黄丸等方剂加减组合。随着支持度的增加, 组方药味个数逐渐减少, 最常用的药物组合逐渐聚焦, 发现当归、丹参、赤芍、红花、茯苓、甘草为先生最常用的核心药物组合。前四味药为具有补血行血、活血散瘀、调经止痛之功的药物, 甘草调和诸药, 为基本组方用药, 茯苓常用于与其它药物相须或相使为用。

在支持度为 50%, 即至少 211 首处方中出现过某药物组合, 置信度为 0.90, 共得到 64 条常用药物组合模式, 见附表 4。共包含红花、丹参、当归、赤芍、黄芪、茯苓、山茱萸、山药、甘草 9 味中药, 结合附表 5 关联规则分析, 在药物置信度较高及关联系数较高的组合中均以养血活血、补肾活血为主, 且附表 4 中用药模式组合出现频数最高者为 (丹参, 当归), 为 375 次, 说明先生尤其重视理血药与其它药物的配伍使用, 根据不同的配伍而发挥着不同的疗效。

3. 新方分析结果讨论

基于复杂熵聚类的研究方法, 挖掘出 8 对核心药物组合, 由此经过熵层次聚类得到的 8 组新处方从理论上可体现先生随体质用药的治则, 如新方 1 号 (木香、陈皮、焦麦芽、砂仁、姜半夏), 具有健脾、燥湿、理气之功, 可用于痰湿质体质导致的经期食欲不振、恶心、暖气等; 新方 2 号 (防风、白芷、前胡、菊花、羌活), 具有祛风散邪, 清热化痰的作用, 可用于气虚体质经期外感者; 新方 3 号 (连翘、金银花、板蓝根、生地黄、蒲公英), 清热泻火、凉血止血, 可治疗因阳盛引起的血热, 而导致经期痤疮, 经行吐衄等; 新方 4 号 (全蝎、琥珀、藁本、姜黄) 具有熄风镇静, 活血止痛之功效, 可用于血瘀重者, 治疗头痛身痛, 心神不宁等; 新方 5 号 (黄芩、茯苓、杜仲、山药、山茱萸、桃仁), 8 号 (山药、山茱萸、桃仁、枸杞子、茯苓、杜仲) 均可治疗因肾虚而引起的血瘀, 5 号偏于因血瘀化热而导致的咳血, 目赤肿痛, 高血压等, 8 号重在补肾填精; 新方 6 号 (胆南星、橘红、芥子、杏仁、桔梗、前胡), 7 号 (胆南星、芥子、槐角、煅瓦楞子、炒山药) 均能祛痰化湿, 6 号偏于清肺止咳, 7 号偏于收敛固涩, 制酸止血。

以上 8 种新方，基于药物之间的配伍，理论可行，但实际临床价值需要进一步的研究与验证。

结 语

正如大多数名老中医一样，先生在面对生活的困苦，学业的繁重困惑，能始终坚持本心，苦学巧记，一点一滴认真学习中医基础知识。对待病人耐心认真，能察病人之苦，体病人之情，医患之间关系融洽，深受病人尊敬。又能勤求古训，虚心求学，博采众长，逐渐成长为一方名医。月经病作为妇科病之首，与女性生活息息相关，基于田代华教授的学术成就与特色来对其治疗月经病的学术思想及临证经验进行研究，得出以下 2 条结论。

一、重视脾肾，注重调理气血。先生治疗月经病惯从气血入手调理月经，虚则补，滞则通，寒则温，热则清，使气血通达和畅，通过对其组方用药的分析，发现高频用药、常用药物组合模式以及药物间的关联规则，发现多为补血活血祛瘀的药物，验证其以血为本的月经病思想，而调气药多为理气行气之药，气行血亦行，气滞血亦瘀，符合其月经以气为用的观点；专注于补肾健脾，认为脾肾二脏与月经关系密切，从根源上解决气血虚弱引起的月经病症，同时纠正肾之阴阳失衡，顾护肾气。虚证多以补肾健脾，益气养血为主，实证多以疏肝理气，活血祛瘀为主。另外，对月经病用药进行的数据分析，印证了先生治疗月经病的基本原则。

二、分年龄论治，重视体质对月经病的影响。善从不同年龄阶段女性体质、病因、病机治疗月经病。青春期发病多由于气血偏虚，体质以气、血虚等型居多，治疗当以补肾健脾，益气养血为主；生育期发病多与气滞、肾虚相关，体质以气滞、血瘀等型居多，治疗当以理气活血，补肾疏肝为主；更年期发病多与血瘀、肾之阴阳失调相关，体质以血瘀、阴虚、气滞等型居多，治疗当以补益肝肾，活血化瘀为主。月经病的临床治疗以体质学说为理论指导，有利于提高治疗效果，为月经病的中医调护和诊疗提供理论基础。

由于病历记录出自多人之手，症状描述不尽规范统一，未进行月经病证候及相关病史、检查等数据的录入，未能进行先生治疗月经病证候、体质、用药之间的相关性分析研究，是为本论文缺憾之处。部分病历时间久远，未能进行后期疗效的验证，使论证强度有所限制。

参考文献

- [1] (明)李时珍著;张守康,张向群,王国辰等点校.本草纲目[M].北京:中国中医药出版社,1998.
- [2] (清)吴谦著;石学文点校.医宗金鉴[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1997:418.
- [3] 张玉珍主编.中医妇科学[M].北京:中国中医药出版社,2017.
- [4] (清)沈金鳌著;郭瑞华点校.妇科玉尺[M].天津:天津科学技术出版社,2000.
- [5] 杨洪军,唐仕欢,卢朋主编.中医传承辅助平台的开发与应用[M].福州:福建科学技术出版社,2013.
- [6] 中共山东省委组织部,山东省人事厅.山东省有重要贡献专家名录[M].济南:山东科学技术出版社,1999:795.
- [7] 张奇文,柳少逸,郑其国主编.名老中医之路续编 第2辑[M].北京:中国中医药出版社,2010.
- [8] (清)王鸣盛著;黄曙辉点校.十七史商榷[M].上海:上海书店出版社,2005:12.
- [9] 张舜徽著.广校雠略[M].上海:上海古籍出版社,2013:52-53.
- [10] 佚名.黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,2012.
- [11] (清)段玉裁著;钟敬华点校.经韵楼集[M].上海:上海古籍出版社,2008:191.
- [12] 徐国仟,张灿理,田代华.中医文献学[M].济南:山东中医学院出版,1988:109.
- [13] (唐)孙思邈著.备急千金要方[M].北京:人民卫生出版社,1982.
- [14] 田代华,刘更生点校.灵枢经[M].北京:人民卫生出版社,2005.
- [15] 金丽.田代华教授内科临证经验探讨[J].辽宁中医学院学报,2001(01):27-28.
- [16] (清)徐灵胎著;刘洋点校.医学源流论[M].北京:中国中医药出版社,2008:17.
- [17] (清)费伯雄著;(清)徐相任校,(清)朱祖怡注.校注医醇胜义[M].上海:上海科学技术出版社,1959:78.
- [18] 马艳,武少玮,杨金萍.基于田代华教授临床经验的三维辨证体系研究[J].四川中医,2016,34(03):3-5.
- [19] (金)刘完素著;宋乃光校注.素问病机气宜保命集[M].北京:中国中医药出版社,2007.
- [20] 陈萌主编.中医学基础[M].北京:中国中医药出版社,2016:18.
- [21] (清)何梦瑶著;邓铁涛,刘纪莎点校.医碥[M].北京:人民卫生出版社,1994:433.
- [22] (明)张景岳著;夏之秋校注.景岳全书[M].北京:中国中医药出版社,1994.
- [23] (明)张景岳著;罗元恺点注.妇人规[M].广州:广东科技出版社,1984.
- [24] (隋)巢元方著;黄作阵点校.诸病源候论[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1997.
- [25] (宋)赵佶敕编;王振国,杨金萍点校.圣济总录校注[M].上海:上海科学技术出版社,2016:1424.
- [26] (元)朱震亨著;刘更生点校.格致余论[M].天津:天津科学技术出版社,2000:2.

- [27] (清)唐宗海著;魏武英,曹健生点校.血证论[M].北京:人民卫生出版社,1990.
- [28] (清)张璐著;李静芳,建一校注.张氏医通[M].北京:中国中医药出版社,1995:100.
- [29] (清)吴本立撰;余德友点校.女科切要[M].北京:中医古籍出版社,1999:1.
- [30] (清)沈金鳌撰;李占永,李晓林校注.杂病源流犀烛[M].北京:中国中医药出版社,1994.
- [31] (明)马蒔著.黄帝内经注证发微[M].北京:中医古籍出版社,2017:6.
- [32] (明)张景岳著;郭洪耀,吴少楨校注.类经[M].北京:中国中医药出版社,1997.
- [33] (清)冯兆张纂辑;田思胜,高萍,戴敬岚等校注.冯氏锦囊秘录[M].北京:中国中医药出版社,1996:682.
- [34] (金)李杲著;包来发,金芷君点校.病机沙篆[M].北京:中国中医药出版社,2015:433.
- [35] (明)薛己著.校注妇人良方[M].上海:科技卫生出版社,1958:34.
- [36] (清)叶天士著;艾军,戴铭,姚春等校注.临证指南医案[M].北京:中国中医药出版社,2008.
- [37] (明)赵献可著.邯郸遗稿[M].杭州:浙江科学技术出版社,1984:19.
- [38] (清)魏之琇编;黄汉儒,蒙木荣,廖崇文等点校.续名医类案[M].北京:人民卫生出版社,1997:716.
- [39] 林丹.论妇女冲任之本[J].海南大学学报(自然科学版),1995,13(04):360-361+364.
- [40] 孙桐,蔡建伟编.难经[M].北京:中国医药科技出版社,1998:57.
- [41] 罗元恺著.罗元恺论医集[M].北京:人民卫生出版社,1990:17-21.
- [42] 林至君.简化中药人工周期三联法治疗排卵功能障碍不孕的临床观察[J].中西医结合杂志,1986,6(12):717.
- [43] (明)赵献可著.医贯[M].北京:人民卫生出版社,1982:4.
- [44] (明)虞抟著;郭瑞华,马湃,王爱华等点校.医学正传[M].北京:中医古籍出版社,2002:396.
- [45] (清)傅山著;欧阳兵,张成博点校.傅青主女科[M].天津:天津科学技术出版社,1999.
- [46] (金)李杲著;张艳军,徐立,王卫等点校.医宗必读[M].天津:天津科学技术出版社,1999:6.
- [47] 向玮.仲景治疗妇人病重视脾胃的学术思想研究[D].北京:北京中医药大学,2012.
- [48] 秦伯未编纂.清代名医医案精华[M].上海:上海科学技术出版社,1959:339.
- [49] (清)杨时泰著.本草述钩元释义[M].太原:山西科学技术出版社,2009:559.
- [50] (明)方隅集撰;王小岗,贾晓凡校注.医林绳墨[M].北京:中医古籍出版社,2012:272-273.
- [51] (宋)陈自明著;田代华,宋咏梅,何永点校.妇人大全良方[M].天津:天津科学技术出版社,2003.
- [52] (清)程杏轩著.医述[M].合肥:安徽人民出版社,1959:8.
- [53] (明)薛己著;吴小明,王勇,魏宝荣等校注.女科撮要[M].北京:中国中医药出版社,2015:5.
- [54] (明)万全著;罗田县卫生局校注.万氏妇人科[M].武汉:湖北人民出版社,1983.
- [55] (宋)严用和撰;王道瑞,申好真重辑.重辑严氏济生方[M].北京:中国中医药出版社,2007:182.
- [56] (明)龚廷贤著;朱广仁点校.万病回春[M].天津:天津科学技术出版社,1993:372.

- [57] (清) 郑玉坛撰;江凌圳校注. 彤园妇人科[M]. 北京:中国中医药出版社, 2015:10.
- [58] (宋) 杨士瀛撰. 仁斋直指[M]. 北京:中医古籍出版社, 2016:505.
- [59] (元) 朱震亨著. 金匱钩玄[M]. 北京:人民卫生出版社, 1980:46.
- [60] 王琦. 9 种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据[J]. 北京中医药大学学报, 2005, 28 (4):1.
- [61] (清) 沈尧封著; (清) 张山雷笺正. 沈氏女科辑要笺正[M]. 上海:上海卫生出版社, 1959.
- [62] (宋) 薛轩著;林士毅, 周坚, 滕依丽等校注. 坤元是保[M]. 北京:中国中医药出版社, 2015:14.
- [63] (明) 龚廷贤著;王均宁, 刘更生, 毛淳点校. 寿世保元[M]. 天津:天津科学技术出版社, 1999:464-465.
- [64] (宋) 陈素庵著;杜惠芳, 张晋峰, 李萌等注. 陈素庵妇科补解[M]. 北京:人民军医出版社, 2012.
- [65] (魏) 吴普述; (清) 孙星衍, 孙冯翼辑;鲁兆麟, 石学文点校. 神农本草经[M]. 沈阳:辽宁科学技术出版社, 1997.
- [66] 张锡纯著. 医学衷中参西录[M]. 石家庄:河北科学技术出版社, 2017:349.
- [67] 常敏毅辑注. 日华子本草辑注[M]. 北京:中国医药科技出版社. 2016.
- [68] (唐) 甄权著;尚志钧辑校. 药性论[M]. 芜湖:皖南医学院科研科, 1983:27.
- [69] (清) 黄元御著;吴少祯, 王应泉, 许军等编. 玉楸药解[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2017:40.
- [70] (清) 黄宫绣著;王淑民校注. 本草求真[M]. 北京:中国中医药出版社, 1997.
- [71] (金) 李杲著;张年顺校注. 兰室秘藏[M]. 北京:中国中医药出版社, 2007:66.
- [72] (清) 徐大椿著. 神农本草经百种录[M]. 北京:人民卫生出版社, 1956:40.
- [73] (清) 张秉成著. 本草便读[M]. 上海:上海卫生出版社, 1958:2.
- [74] (清) 严西亭, 施澹宁, 洪缉菴纂. 得配本草[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1958:27.
- [75] (清) 张山雷著;程东旗点校. 本草正义[M]. 福州:福建科学技术出版社, 2006:16.
- [76] (明) 张景岳著;吴少祯, 王应泉, 许军等编. 本草正[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2017:4.
- [77] (清) 汪昂编撰;余力, 陈赞育校注. 本草备要[M]. 北京:中国中医药出版社, 1998:73.
- [78] (明) 倪朱谟撰;郑金生, 甄雪燕, 杨梅香校点. 本草汇言[M]. 北京:中医古籍出版社, 2005:130.
- [79] (金) 张元素著;任应秋点校. 医学启源[M]. 北京:人民卫生出版社, 1978:186.
- [80] (清) 陈士铎著;裴效华, 田松, 孙志良等校注. 石室秘录[M]. 太原:山西科学技术出版社, 2011:127.

附 录

附表 1 中药名称统一规范表

统一规范前	统一规范后
山萸肉	山茱萸
怀山药	山药
丹皮	牡丹皮
川牛膝	牛膝
乌贼骨	海螵蛸
双花	金银花
川朴	厚朴
川断	续断
夜交藤	首乌藤
蝉衣、蝉蜕	蝉蜕
龙胆草	龙胆
元胡	延胡索
胆星	胆南星
玉蝴蝶	木蝴蝶
墨旱莲	旱莲草
苏子	紫苏子
白芥子	芥子
白蔻仁	白豆蔻
公英	蒲公英
煅瓦楞	煅瓦楞子
生薏米	薏苡仁
杭白芍、白芍	白芍
仙灵脾、淫羊藿	淫羊藿
坤草、益母草	益母草
生龙牡	龙骨、牡蛎
赤白芍	赤芍、白芍
苍白术	苍术、炒白术
焦三仙	焦山楂、焦麦芽、焦神曲

附表 2 月经病中药频次统计表

序号	中药名称	频次	序号	中药名称	频次	序号	中药名称	频次
1	甘草	426	69	焦神曲	18	137	菟丝子	4
2	当归	416	70	生地黄	17	138	车前子	3
3	丹参	376	71	桂枝	16	139	首乌藤	3
4	赤芍	371	72	柏子仁	15	140	海螵蛸	3
5	茯苓	344	73	川楝子	15	141	黄精	3
6	红花	300	74	熟地黄	15	142	辛夷	3
7	黄芪	269	75	浮小麦	13	143	益智仁	3
8	山茱萸	234	76	杏仁	13	144	麦芽	3
9	山药	226	77	龙眼肉	12	145	蒲黄	3
10	香附	198	78	夏枯草	12	146	煅龙骨	3
11	党参	195	79	连翘	12	147	紫草	3
12	川芎	194	80	茵陈	12	148	木瓜	3
13	益母草	180	81	防风	12	149	银柴胡	3
14	炒白术	178	82	枳壳	12	150	百合	2
15	牡丹皮	161	83	葛根	12	151	桑白皮	2
16	柴胡	136	84	威灵仙	11	152	牛蒡子	2
17	杜仲	127	85	附子	11	153	酸枣仁	2
18	炒枣仁	126	86	合欢花	11	154	熟大黄	2
19	延胡索	96	87	胆南星	11	155	制何首乌	2
20	牡蛎	91	88	枳实	11	156	天花粉	2
21	龙骨	91	89	前胡	10	157	乌梅	2
22	桑寄生	89	90	炒白芍	10	158	三七	2
23	白芍	85	91	地骨皮	10	159	栀子	2
24	蒲公英	81	92	淫羊藿	10	160	槟榔	2
25	薏苡仁	80	93	煅瓦楞子	9	161	合欢皮	2
26	桃仁	78	94	泽泻	9	162	蛇床子	2
27	郁金	75	95	地龙	9	163	紫苏子	2
28	黄柏	74	96	续断	9	164	巴戟天	2
29	山慈菇	73	97	白鲜皮	9	165	干姜	2
30	枸杞子	65	98	何首乌	8	166	桑螵蛸	2
31	乌药	63	99	补骨脂	8	167	羌活	2
32	黄芩	62	100	麻黄根	8	168	莱菔子	2
33	苍术	62	101	炒山药	8	169	泽兰	2
34	陈皮	60	102	滑石	8	170	白扁豆	2
35	清半夏	59	103	朱砂	7	171	石膏	2
36	金银花	58	104	百部	7	172	生姜	2
37	五味子	51	105	竹茹	7	173	佩兰	1
38	木香	51	106	琥珀	7	174	人参	1
39	白芷	50	107	三七粉	7	175	白附子	1
40	肉桂	46	108	蝉蜕	7	176	蜈蚣	1
41	知母	44	109	苦参	7	177	北沙参	1

42	石菖蒲	43	110	芡实	6	178	苍耳子	1
43	桔梗	43	111	全蝎	6	179	野菊花	1
44	女贞子	41	112	板蓝根	6	180	苏梗	1
45	厚朴	38	113	芥子	6	181	山楂	1
46	牛膝	37	114	细辛	6	182	地榆炭	1
47	麦冬	37	115	玄参	6	183	大枣	1
48	砂仁	32	116	浙贝母	6	184	石决明	1
49	焦栀子	32	117	薤白	6	185	血余炭	1
50	瓜蒌	29	118	升麻	6	186	炙麻黄	1
51	藿香	29	119	珍珠母	6	187	生石膏	1
52	僵蚕	29	120	莲子肉	5	188	龙胆	1
53	鸡内金	27	121	火麻仁	5	189	木蝴蝶	1
54	橘红	27	122	白茅根	5	190	小蓟	1
55	土茯苓	25	123	刺蒺藜	5	191	大蓟	1
56	鸡血藤	25	124	大黄	5	192	姜黄	1
57	肉苁蓉	24	125	旱莲草	5	193	磁石	1
58	天麻	22	126	薄荷	5	194	神曲	1
59	莪术	21	127	槐角	5	195	橘核	1
60	炒麦芽	21	128	全瓜蒌	5	196	肉豆蔻	1
61	阿胶	20	129	猪苓	4	197	五灵脂	1
62	黄连	20	130	橘络	4	198	莲子心	1
63	三棱	20	131	吴茱萸	4	199	小茴香	1
64	荆芥	18	132	白豆蔻	4	200	钩藤	1
65	姜半夏	18	133	远志	4	201	旋覆花	1
66	焦山楂	18	134	佛手	4			
67	焦麦芽	18	135	白及	4			
68	菊花	18	136	藁本	4			

附表3 月经病主要中药门类表（频次≥100）

序号	中药门类	频次	具体中药
1	补血药	416	当归（416）
2	活血调经药	856	丹参（376）、红花（300）、益母草（180）
3	活血止痛药	194	川芎（194）
4	清热凉血药	532	赤芍（371）、牡丹皮（161）
5	补气药	1294	甘草（426）、黄芪（269）、山药（226）、党参（195）、炒白术（178）、
6	固精缩尿止带药	234	山茱萸（234）
7	理气药	198	香附（198）
8	补阳药	127	杜仲（127）
9	利水渗湿药	344	茯苓（344）

10	养心安神药	126	炒枣仁（126）
11	发散风热药	136	柴胡（136）

附表 4 用药组合模式表（支持度个数 211，置信度 0.90）

序号	药物模式	出现频数
1	丹参， 当归	375
2	赤芍， 当归	371
3	甘草， 当归	370
4	赤芍， 丹参	343
5	赤芍， 丹参， 当归	343
6	当归， 茯苓	340
7	丹参， 甘草	334
8	赤芍， 甘草	333
9	赤芍， 甘草， 当归	333
10	丹参， 甘草， 当归	333
11	丹参， 茯苓	307
12	丹参， 当归， 茯苓	307
13	赤芍， 丹参， 甘草	306
14	赤芍， 丹参， 甘草， 当归	306
15	红花， 当归	300
16	甘草， 茯苓	299
17	赤芍， 茯苓	296
18	赤芍， 当归， 茯苓	296
19	甘草， 当归， 茯苓	295
20	红花， 丹参	287
21	红花， 丹参， 当归	287
22	红花， 赤芍	282
23	红花， 赤芍， 当归	282
24	赤芍， 丹参， 茯苓	276
25	赤芍， 丹参， 当归， 茯苓	276
26	红花， 甘草	270
27	红花， 赤芍， 丹参	270
28	红花， 甘草， 当归	270
29	红花， 赤芍， 丹参， 当归	270
30	丹参， 甘草， 茯苓	266
31	丹参， 甘草， 当归， 茯苓	266
32	赤芍， 甘草， 茯苓	259
33	赤芍， 甘草， 当归， 茯苓	259
34	红花， 丹参， 甘草	258
35	红花， 丹参， 甘草， 当归	258
36	红花， 赤芍， 甘草	254

37	红花, 赤芍, 甘草, 当归	254
38	红花, 赤芍, 丹参, 甘草	243
39	红花, 赤芍, 丹参, 甘草, 当归	243
40	赤芍, 丹参, 甘草, 茯苓	240
41	赤芍, 丹参, 甘草, 当归, 茯苓	240
42	红花, 茯苓	238
43	红花, 当归, 茯苓	238
44	黄芪, 当归	233
45	红花, 丹参, 茯苓	232
46	红花, 丹参, 当归, 茯苓	232
47	山茱萸, 当归	231
48	山茱萸, 山药	224
49	山药, 当归	223
50	山茱萸, 茯苓	221
51	山茱萸, 山药, 当归	221
52	红花, 赤芍, 茯苓	220
53	红花, 赤芍, 当归, 茯苓	220
54	山茱萸, 当归, 茯苓	218
55	黄芪, 甘草	217
56	山药, 茯苓	216
57	山茱萸, 山药, 茯苓	215
58	红花, 赤芍, 丹参, 茯苓	215
59	红花, 赤芍, 丹参, 当归, 茯苓	215
60	黄芪, 甘草, 当归	213
61	山药, 当归, 茯苓	213
62	山茱萸, 丹参	212
63	山茱萸, 丹参, 当归	212
64	山茱萸, 山药, 当归, 茯苓	212

附表5 关联规则分析表（支持度个数 211，置信度 0.90）

序号	规则	置信度
1	红花 → 当归	1
2	赤芍 → 当归	1
3	红花, 赤芍 → 当归	1
4	红花, 丹参 → 当归	1
5	红花, 甘草 → 当归	1
6	红花, 茯苓 → 当归	1
7	赤芍, 丹参 → 当归	1
8	赤芍, 甘草 → 当归	1
9	赤芍, 茯苓 → 当归	1
10	丹参, 茯苓 → 当归	1
11	山茱萸, 丹参 → 当归	1

12	红花, 赤芍, 丹参 -> 当归	1
13	红花, 赤芍, 甘草 -> 当归	1
14	红花, 赤芍, 茯苓 -> 当归	1
15	红花, 丹参, 甘草 -> 当归	1
16	红花, 丹参, 茯苓 -> 当归	1
17	赤芍, 丹参, 甘草 -> 当归	1
18	赤芍, 丹参, 茯苓 -> 当归	1
19	赤芍, 甘草, 茯苓 -> 当归	1
20	丹参, 甘草, 茯苓 -> 当归	1
21	红花, 赤芍, 丹参, 甘草 -> 当归	1
22	红花, 赤芍, 丹参, 茯苓 -> 当归	1
23	赤芍, 丹参, 甘草, 茯苓 -> 当归	1
24	丹参 -> 当归	0.997340426
25	丹参, 甘草 -> 当归	0.997005988
26	山药, 茯苓 -> 山茱萸	0.99537037
27	山药, 当归, 茯苓 -> 山茱萸	0.995305164
28	山药 -> 山茱萸	0.991150442
29	山药, 当归 -> 山茱萸	0.99103139
30	茯苓 -> 当归	0.988372093
31	山茱萸 -> 当归	0.987179487
32	山药 -> 当归	0.986725664
33	甘草, 茯苓 -> 当归	0.986622074
34	山茱萸, 山药 -> 当归	0.986607143
35	山茱萸, 茯苓 -> 当归	0.986425339
36	山药, 茯苓 -> 当归	0.986111111
37	山茱萸, 山药, 茯苓 -> 当归	0.986046512
38	甘草 -> 当归	0.984042553
39	黄芪 -> 当归	0.983122363
40	黄芪, 甘草 -> 当归	0.98156682
41	红花, 赤芍, 茯苓 -> 丹参	0.977272727
42	红花, 赤芍, 当归, 茯苓 -> 丹参	0.977272727
43	红花, 赤芍, 茯苓 -> 丹参, 当归	0.977272727
44	红花, 茯苓 -> 丹参	0.974789916
45	红花, 当归, 茯苓 -> 丹参	0.974789916
46	红花, 茯苓 -> 丹参, 当归	0.974789916
47	山茱萸, 茯苓 -> 山药	0.972850679
48	山茱萸, 当归, 茯苓 -> 山药	0.972477064
49	山茱萸, 山药 -> 茯苓	0.959821429
50	山茱萸, 山药, 当归 -> 茯苓	0.959276018
51	山茱萸, 茯苓 -> 山药, 当归	0.959276018
52	红花, 赤芍 -> 丹参	0.957446809
53	红花, 赤芍, 当归 -> 丹参	0.957446809
54	红花, 赤芍 -> 丹参, 当归	0.957446809
55	山茱萸 -> 山药	0.957264957

56	山茱萸, 当归 -> 山药	0.956709957
57	红花, 赤芍, 甘草 -> 丹参	0.956692913
58	红花, 赤芍, 甘草, 当归 -> 丹参	0.956692913
59	红花, 赤芍, 甘草 -> 丹参, 当归	0.956692913
60	红花 -> 丹参	0.956666667
61	红花, 当归 -> 丹参	0.956666667
62	红花 -> 丹参, 当归	0.956666667
63	山药 -> 茯苓	0.955752212
64	红花, 甘草 -> 丹参	0.955555556
65	红花, 甘草, 当归 -> 丹参	0.955555556
66	红花, 甘草 -> 丹参, 当归	0.955555556
67	山药, 当归 -> 茯苓	0.955156951
68	山药, 当归 -> 山茱萸, 茯苓	0.950672646
69	山茱萸, 山药 -> 当归, 茯苓	0.946428571
70	山茱萸 -> 茯苓	0.944444444
71	山茱萸 -> 山药, 当归	0.944444444
72	山茱萸, 当归 -> 茯苓	0.943722944
73	山药 -> 当归, 茯苓	0.942477876
74	红花, 丹参, 甘草 -> 赤芍	0.941860465
75	红花, 丹参, 甘草, 当归 -> 赤芍	0.941860465
76	红花, 丹参 -> 赤芍	0.940766551
77	红花, 丹参, 当归 -> 赤芍	0.940766551
78	红花, 甘草 -> 赤芍	0.940740741
79	红花, 甘草, 当归 -> 赤芍	0.940740741
80	红花 -> 赤芍	0.94
81	红花, 当归 -> 赤芍	0.94
82	红花 -> 赤芍, 当归	0.94
83	山药 -> 山茱萸, 当归, 茯苓	0.938053097
84	赤芍, 茯苓 -> 丹参	0.932432432
85	赤芍, 当归, 茯苓 -> 丹参	0.932432432
86	赤芍, 茯苓 -> 丹参, 当归	0.932432432
87	山茱萸 -> 当归, 茯苓	0.931623932
88	红花, 丹参, 茯苓 -> 赤芍	0.926724138
89	红花, 丹参, 当归, 茯苓 -> 赤芍	0.926724138
90	红花, 丹参, 茯苓 -> 赤芍, 当归	0.926724138
91	赤芍, 甘草, 茯苓 -> 丹参	0.926640927
92	赤芍, 甘草, 当归, 茯苓 -> 丹参	0.926640927
93	赤芍, 甘草, 茯苓 -> 丹参, 当归	0.926640927
94	赤芍 -> 丹参	0.924528302
95	赤芍, 当归 -> 丹参	0.924528302
96	赤芍 -> 丹参, 当归	0.924528302
97	红花, 茯苓 -> 赤芍	0.924369748
98	红花, 当归, 茯苓 -> 赤芍	0.924369748
99	红花, 茯苓 -> 赤芍, 当归	0.924369748

100	赤芍, 甘草 -> 丹参	0.918918919
101	丹参, 甘草, 当归 -> 赤芍	0.918918919
102	赤芍, 甘草, 当归 -> 丹参	0.918918919
103	赤芍, 甘草 -> 丹参, 当归	0.918918919
104	山茱萸 -> 山药, 茯苓	0.918803419
105	山茱萸, 当归 -> 丹参	0.917748918
106	山茱萸, 当归 -> 山药, 茯苓	0.917748918
107	丹参, 甘草 -> 赤芍	0.916167665
108	黄芪 -> 甘草	0.915611814
109	丹参, 当归 -> 赤芍	0.914666667
110	黄芪, 当归 -> 甘草	0.91416309
111	丹参 -> 赤芍	0.912234043
112	山茱萸 -> 丹参	0.905982906
113	山茱萸 -> 丹参, 当归	0.905982906
114	山茱萸 -> 山药, 当归, 茯苓	0.905982906
115	红花, 茯苓 -> 赤芍, 丹参	0.903361345
116	红花, 当归, 茯苓 -> 赤芍, 丹参	0.903361345
117	红花, 茯苓 -> 赤芍, 丹参, 当归	0.903361345
118	当归, 茯苓 -> 丹参	0.902941176
119	丹参, 甘草, 茯苓 -> 赤芍	0.902255639
120	丹参, 甘草, 当归, 茯苓 -> 赤芍	0.902255639
121	甘草, 当归, 茯苓 -> 丹参	0.901694915
122	当归 -> 丹参	0.901442308
123	红花, 赤芍 -> 甘草	0.90070922
124	红花, 赤芍, 当归 -> 甘草	0.90070922
125	红花, 赤芍 -> 甘草, 当归	0.90070922

致 谢

时光如水，静静流淌，转眼间我的硕士生活即将结束，回首过去，心中思绪万千，有千言万语，却不知从何说起。

机缘巧合之下进入师门。犹记初次面见导师时紧张忐忑的心情，那时对老师的第一印象是能言善谈、平易近人、性格爽快。在后面的相处中，老师的人品、性格、治学，对我产生了很深的影响。我的老师张成博为人热忱、胸怀坦荡、爱憎分明，对学生最基本的要求是保证人品，我的底线也从健康的生活变成了做一个保证人品，健康生活的人。“君子慎独，不欺暗室”，成为我的人生格言，不求品格如何高洁，但求问心无愧。老师常感叹愧对学生，未尽好为师之责，我想说的是“在其位，谋其政”，老师已经做得很好了，不要再自责。况且“师傅领进门，修行在个人”工作繁忙之余既已传道、授业、解惑，那么剩下的就是学生的个人修行，成年人应当自律。本人性格偏于内向，不善言辞，老师让我跟随田代华先生学习，也是基于这一点。老师对所带每位学生做到了因材施教，公平公正。老师为学生所做得一切，铭记心中，不敢忘却。成为我导的学生，是我之幸，亦是我之福。

小时候经常生病，父母为我的身体状况担忧诸多，在外求学，父母嘱咐最多的就是“好好吃饭；按时吃饭；多穿点，别感冒了”，年少不懂事时也曾嫌父母唠叨，每次通话时耐心甚微。人们总是这样，面对至亲之人时肆无忌惮的发泄各种情绪。后来不记得哪一次，突然意识到，我为何面对父母时如此没有耐心，在他人面前却耐心十足。所以现在常常告诫自己，对待父母要耐心、耐心、再耐心，不要逞口舌之快，顶撞父母。感谢父母给予我生命，27年来对我的辛勤抚养，学业上默默支持与鼓励。想来惭愧，庸庸碌碌近30年，依旧一事无成，再谢父母一如既往的鼓励与支持，让我有继续前行的勇气。

特别感谢田代华先生对本论文的支持与帮助。先生性格随和，安静内敛，在跟随学习期间，对我认真教导，指出我的不足，关心我的生活。其夫人姬奶奶性格与先生互补，活泼开朗，是位和蔼可亲的老太太，让人心生亲近。每周六随诊学习，姬奶奶都不辞辛苦给我们准备可口的饭菜，让我尤其感动。在跟诊过程中，还结识了几位可爱的小伙伴，梦琦、小裴、寰宇等等，大家互相帮助，共同进步。

“学贵得师，亦贵得友”衷心地感谢文献所的诸位师长，每位老师都毫无保留地

传授自己的学识，不求回报的帮助学生。特别感谢宋咏梅老师对我论文的指导，生活中的各种帮助，为我排忧解难。我是一个特别幸运的人，进入一个特别团结有爱的师门，知识渊博的刘鹏师兄常教育我们人生苦短，要多读书，惭愧未能静下心来读书，仅做到不午睡。感谢师姐罗光芝对我从始至终的悉心关怀，为我排忧解难。特别感谢光芝师姐的爱人韩成恩师哥，能在我每次去当电灯泡的时候，做饭招待。感谢王迪师姐对我的关心，在我失意难过时，立马放下手头工作来安慰我，鼓励我。还有可爱的张佳雯师妹，对我的鼓励与支持，是我生活中的快乐源泉。感谢我可爱的室友们：刘雪、竹青、郑姐对我的包容与帮助，生活中的喜怒哀乐，点点滴滴，使我们共同进步。感谢孟玺师哥对我的帮助与鼓励，感谢共读多年的同窗们，在学习上、生活中的互相支持与帮助。还有太多太多感谢的人，感谢你们出现在我的生命中，带来温暖与美好，谢谢！

临表涕零，不知所言。亲爱的师长、父亲母亲、师哥师姐、同学们，无论前路如何，祝你们永远平安、健康、幸福！

论文著作



中国科技核心期刊
中国科技论文统计源期刊
中国生物医学核心期刊
中国期刊方阵双效期刊
中国高校优秀科技期刊
全国优秀中医药期刊
山东省十佳期刊

ISSN0257-358X
CN37-1164/R

山东中医杂志

SHANDONG JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

SHANDONG ZHONGYI ZAZHI

主办 山东中医药学会 山东中医药大学



2018.11

2018年第37卷总第373期

山东中医杂志

(月刊)

1981年10月创刊

2018年第37卷第11期

(总第373期)

(2018年11月5日出版)

中国标准刊号 ISSN 0257-358X

CN 37-1164X

国内发行代号 24-044

国外发行代号 M826

主编 武继祖

副主编 高树中 张成博

执行主编 李晓明

主管 山东省卫生和计划生育委员会

主办 山东中医药大学

山东中医药大学

编辑出版 《山东中医杂志》

编辑部

地址 济南市历城区大学路4655号

山东中医药大学

(邮政编码250355)

电话 (0531)89628058(编辑部)

89628059(编务室)

印刷 济南新科印务有限公司

国内发行 济南市邮政局

国外发行 中国国际图书贸易总公司

(100044,北京399信箱)

广告经营许可证 3700004000092号

在线投稿 <http://www.sdzy.chinajournal.net.cn>

网址 sdzy.chinajournal.net.cn

国内定价 6.00元



欢迎关注本刊微信号

目次

●名家论坛

针灸干预的作用特征与自稳态机制 陈少宗 朱 兵(877)

●学术探讨

基于运气理论与体质学说探讨丁酉年阴虚质高血压患者诊疗规律
..... 周国锋 陈玉峰 徐龙进 李 晓(882)

基于颜氏外科探析用药轻简精义的医理
..... 蒯 娟 阙华发(885)

寒热并用论治慢性荨麻疹 胡 雯 林少健(888)

●临床研究

中西医结合治疗肝郁脾虚型功能性消化不良临床研究
..... 张学虹 雷华斌 王成凯 毛 媛(891)

缺血性脑卒中发病时间与五运六气的相关性分析
..... 袁 康 梁文倩 何明丰
李旷怡 张英信 陈显利(896)

老年单纯收缩期高血压肾动脉血流动力学指标与中医证型相关性
研究 王 霖 刘 杨 杨雪松 程 德 张 宇(899)

溃疡病治疗反复性口腔溃疡临床研究
..... 田军官 张国良 丁晓旭(902)

五行音乐配合针刺治疗中风后抑郁临床观察
..... 王 敏 李 丽(906)

郁仁存治疗食管癌经验摘要 张 玉 张 青(909)

阙华发治疗下肢静脉曲张经验 崔慧敏(912)

田代华从体质辨治月经病经验总结
..... 张程程 宋咏梅 张成博(916)

王耀光从脾论治肾性血尿经验 刘 蓉 王丽君(920)

徐瑞荣治疗慢性淋巴细胞白血病经验
..... 王 横 刘 奎 安丰富(922)

赵智强辨治克罗恩病临床经验 陈美玲(925)

急性心肌梗死后失眠辨治临床经验
..... 张 玲 季 晖(928)

田代华从体质辨治月经病经验总结

张程程,宋咏梅,张成博

(山东中医药大学中医文献与文化研究院,山东 济南 250355)

【摘要】田代华教授倡导中医体质学说,认为体质因素不仅影响月经发病,且决定月经病证候类型。认为临床常见月经病发病体质多为气血偏盛体质,且常复合出现,强调对女性月经病的重要性。总结临床治疗月经病常用基础方,临证时将基础方与疾病用药相结合,使方药运用与患者病情更加吻合,并严格按照诊断、治疗、处方等步骤进行诊治,临床收效甚佳。

【关键词】田代华;月经病;体质;临证经验

【中图分类号】R249;R271.11

【文献标志码】A

【文章编号】0257-358X(2018)11-0916-04

DOI:10.16295/j.cnki.0257-358x.2018.11.012

Experience by Professor TIAN Daihua in Treating Menstrual Disease from Body Constitution Differentiation.

ZHANG Chengcheng, SONG Yongmei, ZHANG Chengbo

(Institute of Traditional Chinese Medicine Literature and Culture, Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan 250355, China)

Abstract Professor TIAN Daihua advocates the theory of traditional Chinese medicine (TCM) constitution and believes that body constitution factors not only affect the onset of menstrual disease, but also determine the type of menstrual syndrome. The common body constitution with menstrual disease in clinical practice is qi and blood biased constitution, and often appears in combination. He emphasizes the importance of kidney for menstrual disease. The common used primary formulas for clinical treatment of menstrual disease were summarized. In clinic, the primary formulas are combined with the medicinals variations, so that the prescription is more consistent with the patient's condition. Besides, the diagnosis and treatment are strictly carried out according to the steps of diagnosis, treatment and prescription. The clinical effect is very good.

Keywords TIAN Daihua; menstrual disease; body constitution; clinical experience

月经病指以月经周期、经期、经量、经色、经质等发生异常,或伴随月经周期,或于经前经后出现明显不适症状为特征的疾病^[1]。常见症状有头痛、乳房胀痛、失眠、情绪不稳定、抑郁、焦虑、全身浮肿等,严重时影响正常生活和社会活动,是妇科临床多发病。现一般认为月经的产生,是女子发育到成熟年龄后,脏腑、天癸、气血、经络协调作用于胞宫的现象,与肝、脾、肾三脏关系密切。月经病的主要病机是脏腑功能失调、气血不和,导致冲任二脉损伤。主要病因为外感邪气、内伤七情、房劳多产、饮食不节、劳逸失

常。田代华教授为山东省名老中医药专家,享受国家特殊津贴,曾任山东中医药大学博士研究生导师,全国中医文献学研究会副理事长,山东省中西医结合学会副秘书长等职务,是山东中医药大学中医基础理论与中医文献学专业学术带头人之一。从事中医临床、教学和中医文献研究工作 50 余年,倡导中医体质学说,擅从体质着手治疗月经病,临床收效甚佳。笔者有幸跟随田老师抄方学习,受益匪浅,现将其体质辨治月经病经验总结如下。

1 临证经验

田老师认为体质是产生证候的内在基础,决定着疾病证候的类型,并影响疾病的发生,表现在月经病上亦是如此。

不同的体质偏颇导致发生的月经病各不相同。《景岳全书·妇人规》云:“凡血寒者,经必后期而至。然血何寒?亦惟阳气不足,则寒从内生,而生化失期,是即所谓寒也。”^[2]可见素体偏于阳虚者,发病常见经行后期、经行量少、经行腹痛等。《妇科玉尺》云:

【收稿日期】2018-02-07

【基金项目】教育部人文社会科学规划项目(编号:14YJAZH104)

【作者简介】张程程(1992),女,山东淄博人,2016 年硕士硕士研究生,研究方向:中医临床文献、中国医学史、医籍。

【通信作者】张成博(1961-),男,山东烟台人,教授,博士研究生导师,研究方向:中医临床文献、中国医学史、医籍。

“经水过多不止,平时瘦弱,常发热者,由火旺也。”^[1]素体偏于阳盛者,月经疾病常见经行先期、经行量多、甚或崩漏下等。《坤元是保》云:“冲任虚衰,气不能固也。”^[2]素体气虚,发病常经行先期、经行量多、经行泄泻或者经行延长日久等。《景岳全书·妇人观》云:“凡欲念不遂,沉思积郁,心脾气结,故伤冲任之脉,而肾气日消,轻则或早或迟,重则渐成枯闭。”^[2]若素体抑郁多忧,偏于气郁者,月经病多发经行泄泻、经行量多、经行浮肿。《万密斋医学全书·万氏妇人科》云:“脂痰凝塞者,盖妇女之身,内而肠胃开通,无所阻塞,外而经路流利,无所碍滞,则血气和畅,经水应期。惟痰涎壅滞,膏脂充满,元室之户不开,痰瘀者痰涎壅滞,血海之波不流。故有过期而经始行,或数月而经一行。”^[2]明确提出素体肥胖者多为痰湿体质,脂痰凝滞壅塞胞宫脉络,经络阻滞,冲任不通,痰瘀流注盘踞血海,发病常见经血不行或量少,或后期甚至闭经。月经病的发病与体质有必然联系,临床在月经病辨证论治的整个过程中,始终不应离开对患者体质状况的分析和把握。

田老师认为体质与疾病证候有密切关系。在临床工作中常遇到这样的现象:虽感受不同的致病因素,但由于体质相同,邪随体化,则会表现出相同的疾病证候。如阳盛体质之人,不论春夏秋冬,感寒感热,总是表现为风热表证;气虚体质,分别感受寒邪与热邪,虽病因不同,但临床月经病都会出现痛经、有血块等症状。相反,《灵枢》曾以匠人砍柴比喻,明确提出不同证候表现是由于体质不同造成的^[3]。若感受相同致病因素,但体质类型不同,也会出现不同的证候。如感受湿邪,由于体质阴阳盛衰的不同,结果各异,阳盛体质从阳化热,表现在月经病上多有行经量多或经期长、经色红、质稠或有血块、小腹灼痛拒按、舌红、苔黄腻、脉滑数等湿热证候;阴盛体质则从阴化寒,月经病表现为小腹冷痛、得热痛减、行经量少、色黯有块、肢体酸重、舌黯、苔白腻等寒湿证候。综上所述,体质的差异性决定月经病的易感致病因素和发病类型的倾向性,从而影响月经病的证候类型。

2 辩证论治

田老师以构成人体的基本物质,即阴阳、气血、津液作为体质分类的基础,将人群中个体偏颇的体质分为阴虚、阳虚、气虚、血虚、阳盛、气滞、血瘀、痰湿八种,认为体质除受先天遗传因素影响外,在生长发育过程中,还受后天情志、饮食、疾病、工作或生活环境因素的影响,出现偏颇,这种偏颇导致了脏腑

不协调,从而出现功能与心理的不适,表现出各种症状和体征。所以田老师临床辨体除注重四诊合参外,尚关注患者生活习惯和长期存在的个体特点,如形体肥胖,平素嗜食肥甘厚味者,易生痰湿,属痰湿体质;大便常年质稀,形体消瘦,乏力懒言,纳食不佳者,脾胃虚弱,气血生化不足,多属气虚体质;平素性情急躁,易生气者,肝郁气滞,属气滞体质;平素手脚冰冷,食生冷腹痛腹泻者,脾胃中焦虚寒,属阳虚体质。八种偏颇体质均可导致不同证候的月经病。《景岳全书·血证》云:“人有阴阳,即为血气,阳主气,故气全则神旺;阴主血,故血盛则形强;人生所赖惟斯而已。”^[2]田老师认为,气与血都由人体之精所化,阴阳互根互用,二者相互影响。月经的主要成分血,气为血之帅,气行则血行,气滞则血滞,气虚血亦滞,滞甚则成瘀,气热则血热,气寒血亦寒。气与血在月经的正常潮汛中起重要作用,气血失调则导致月经病发生,故临床月经病体质多见于气、血的偏颇,如气虚质、气滞质、血瘀质等。肾主藏精,内寄真阴真阳,为先天之本,肾气盛才能维持月经的正常潮汛,故月经病常见肾虚证候。田老师根据大量临证经验,认为在实际生活中,由于现代外部环境污染,个人体质情况下降,饮食作息不规律,生活方式加快等,相对于单一体质,复合型体质的偏颇更为常见,使女性月经病辨证更为复杂,临证时务必详细审查患者的体质禀赋,以期有针对性地治疗。

2.1 气虚血瘀型 气虚则冲任不固,血失统摄,可致月经先期、月经过多、崩漏等。《医林改错》云:“元气既虚,必不能达于血管,血管无气,必停留而瘀。”^[4]气为血之帅,血液的正常运行,有赖于气的正常推动,若元气亏虚,无力行血,则血行缓慢,停留而瘀,瘀阻胞脉,可致经行不畅、痛经、崩漏等。根据田老师的中医辨治方法,气虚血瘀治宜益气活血,方用补中益气汤合桃红四物汤加减。药物组成:黄芪 30 g、党参 12 g、茯苓 15 g、白术 12 g、当归 12 g、赤芍 12 g、白芍 12 g、川芎 10 g、桃仁 10 g、红花 10 g、丹参 15 g、甘草 3 g。随症加减。

29 岁,2009 年 9 月 15 日初诊。患者痛经 1 年余。经前腹痛,腰痛,月经量少,色暗,有血块,乳胀。有窦性心律不齐病史,平素胸闷,善太息,双肘浮肿,皮肤有出血紫癜,舌尖红有瘀点,苔薄白,脉律不齐,略沉弦。中医诊断:痛经,证属气虚血瘀,肾虚心弱。治疗宜补气活血,补肾养心,处方:黄芪 30 g,党参 12 g,茯苓 15 g,白术 12 g,当归 15 g,阿胶(烊化) 10 g,赤芍 12 g,白芍 12 g,丹参 15 g,红花 10 g,麦冬

12 g, 五味子 10 g, 山茱萸 15 g, 车前子(包)10 g, 三七 6 g, 怀山药 30 g, 甘草 3 g。7 剂, 水煎服, 日 1 剂。2009 年 9 月 23 日复诊, 述 9 月 20 日月经来潮, 经行 3 d, 初诊症状明显改善。

按: 四诊合参属气虚血瘀体质, 治以益气活血。患者有窦性心律不齐病史, 先天不足, 心气虚弱, 鼓动无力, 心动失常, 故见胸闷、太息, 脉律不齐。冲任之本在肾, 肾气虚弱, 精血不足, 故经量少; 肾气不足, 损及肾阳, 血脉失于温煦, 故经色黯淡; 肾阳不足, 气化无权, 水湿泛溢肌肤, 故双踝浮肿; 肾为腰之外府, 肾虚故腰痛; 心肾两虚, 故见脉沉弱; 气虚无力行血, 可致血瘀; 气虚血瘀则见经前腹痛、血块、乳胀、皮肤出血紫癜、舌红有瘀点。方中用黄芪、党参、白术大补一身之气; 当归、阿胶、赤芍药、丹参、三七、红花活血调经、散瘀止痛; 麦冬、五味子、茯苓、山茱萸、怀山药补肾养心; 车前子、茯苓利水消肿。全方以补气活血为主, 补肾养心为辅, 兼以利水消肿, 共奏活血调经之效。

3.2 气滞血瘀型 月经病可由情志因素引起,《医宗金鉴·妇科心法要诀》云:“妇人从人凡事不得专注, 忧思, 忿怒, 郁气所伤, 故经病因于七情者居多。盖以血之行, 止, 顺, 逆, 皆由一气率之而行也。”^[8]忧郁忿怒, 气机不利, 郁滞不行, 气滞则血瘀, 冲任失常, 导致月经后期, 量少, 痛经, 闭经等, 治宜行气活血、调经冲任。根据田老师的中医辨治方法, 方用柴胡疏肝散合桃红四物汤加减, 药物组成: 柴胡 10 g, 香附 12 g, 郁金 12 g, 枳壳 10 g, 当归 15 g, 赤芍 12 g, 川芎 10 g, 丹参 15 g, 红花 10 g, 桃仁 10 g, 甘草 3 g。随症加减。

女, 32 岁, 2010 年 5 月 18 日初诊。患者月经不规律 3 月余。自春节以来, 月经周期延后, 量少, 色黯。此次月经成血丝状。最近因事烦多, 生气, 烦躁, 食欲不振, 食后腹胀, 呃逆, 大便质稀, 日行 2~3 次, 时有胸闷不舒, 太阳穴痛, 发紧, 怕风, 晨起疲乏。舌尖红, 有红点, 苔薄白, 脉沉弦有力。曾有积奶现象, 有乳腺增生。中医诊断: 月经不调, 证属气滞血瘀、心脾两虚。治疗宜行气活血, 养心健脾, 处方: 柴胡 10 g, 香附 12 g, 郁金 12 g, 黄芩 12 g, 当归 15 g, 赤芍 12 g, 川芎 10 g, 丹参 30 g, 红花 10 g, 桃仁 10 g, 全瓜蒌 15 g, 枳壳 6 g, 茯苓 12 g, 炒麦芽 15 g, 甘草 3 g。14 剂, 水煎服, 日 1 剂。此外, 田老师嘱其保持心情愉悦, 适量运动。2010 年 6 月 1 日复诊, 诸症好转, 月经未来, 继服上方 7 剂, 水煎服。几经复诊调治, 月经

周期, 量色质渐复常态。

按: 本案四诊合参属气滞血瘀体质, 治以行气活血。患者因情绪波动, 使肝气郁结, 气机不畅, 导致气滞, 故见月经后期, 量少, 烦躁, 呃逆, 脉沉弦有力; 肝气郁结, 失于调达, 则胸闷不舒; 气滞则血行不畅而形成气滞血瘀, 故见经色黯, 舌有红点。方用柴胡、香附、川芎、枳壳疏肝解郁, 行气止痛; 当归、川芎、红花、桃仁、赤芍、郁金活血调经; 瓜蒌散结消痞; 炒麦芽回乳消胀; 茯苓健脾宁心。同时嘱患者适量运动, 保持心情愉悦, 使气机条畅, 气行则血行。

3.3 肾虚血瘀型 肾为先天之本, 主藏精气, 是人体生长、发育和生殖的根本, 肾气盛才能维持月经的正常潮汛。田老师十分重视对肾的调理, 认为肾病本质多属于虚, 不论哪个年龄段, 都应首先考虑。肾虚之人免疫力有所下降, 如若伴随气虚、阳虚体质, 推动功能减弱, 则气血运行迟滞或减退; 或平素感寒, 致血行迟缓或凝滞; 或因平素情动, 坐卧时间过长, 缺乏锻炼, 心肌收缩力减弱, 血液运行迟缓均可致瘀。表现在女性时, 常可引起月经不规律, 痛经等^[9]。根据田老师的中医辨治方法, 肾虚血瘀治宜补肾活血。方用六味地黄丸合桃红四物汤加减, 药物组成: 山茱萸 15 g, 怀山药 30 g, 茯苓 12 g, 牡丹皮 12 g, 当归 15 g, 赤芍 12 g, 川芎 10 g, 桃仁 10 g, 红花 10 g, 甘草 3 g。随症加减。

24 岁, 2009 年 6 月 27 日初诊。经间期出血 3 年。患者自 2006 年流产后出现经间期出血, 量少, 色黯, 一般经前持续 2 d, 经后持续 15 d, 月经 3 d 即净, 量少, 色黯, 无血块, 经前乳胀, 经行腰腿酸软, 精神欠佳, 月经后期正常, 易急躁, 眠差多梦。2005 年顺产一子, 2006 年流产 2 次, 现置宫内节育器, 纳可, 大便黏滞, 小便色黄, 舌淡苔薄, 脉沉弦。中医诊断: 经间期出血, 证属肾虚血瘀兼气滞。治疗宜活血祛瘀, 理气补肾, 处方: 山茱萸 12 g, 怀山药 30 g, 茯苓 12 g, 牡丹皮 12 g, 柴胡 10 g, 香附 12 g, 当归 15 g, 赤芍 12 g, 川芎 10 g, 桃仁 10 g, 红花 10 g, 炒酸枣仁 15 g, 焦栀子 12 g, 黄柏 12 g, 甘草 3 g。7 剂, 水煎服, 日 1 剂。2009 年 7 月 4 日二诊, 服药平安, 诸症减轻。自述经间期出血减少, 颜色变淡, 做梦减少, 心情改善, 大便质稀, 日行 3~5 次, 小便黄, 昨日流鼻血。调方如下: 山茱萸 12 g, 怀山药 30 g, 茯苓 12 g, 牡丹皮 12 g, 当归 15 g, 赤芍 12 g, 川芎 10 g, 炒酸枣仁 15 g, 黄柏 12 g, 生苡苡仁 30 g, 白茅根 15 g, 川牛膝 12 g, 蒲公英 15 g, 甘草 3 g。7 剂, 水煎服, 日 1 剂。

2009 年 7 月 25 日三诊,上月月经来潮,月经较前好转,无血块,无腹痛及乳房胀满。经间期出血较前少,色如前,多梦,二便调,舌尖有红点,苔薄,脉沉略数。调方如下:山茱萸 15 g,怀山药 30 g,茯苓 12 g,牡丹皮 12 g,菟丝子 12 g,杜仲 12 g,当归 12 g,赤芍 12 g,白芍 12 g,川芎 10 g,丹参 20 g,生薏苡仁 30 g,炒酸枣仁 15 g,黄柏 12 g,蒲公英 15 g,甘草 3 g。14 剂,水煎服,日 1 剂。此后月经复诊调治,经间期出血痊愈,月经渐复常态。

按:本案患者属以肾虚证候为主的血瘀体质,治宜补肾填精、活血调经。月经中期又称经间期,是冲任月经充实、阳气渐长,由阴盛向阳盛转化的生理阶段,若肾阴不足,肾气虚弱,湿热扰动成瘀血阻遏,使阴阳转化不协调,则发生本病^[1]。患者流产 2 次,致使肾精亏虚,肾阴不足,阳气乘阴,迫血妄行,故经间期出血;阴虚内热,故急躁,小便黄;肾虚则外府失养,故经行腰膝酸软;肾水亏损,不能上济于心,故眠差多梦;“精者,血之所成也”,肾虚血液化生不足,故行经量少,精神欠佳,舌淡苔薄;肾精亏虚,化气减少,则血脉瘀阻,故色黯;血瘀阻碍气行,故见乳胀,脉沉弦。方用山茱萸、怀山药补肾益精;当归、赤芍、川芎、桃仁、红花活血调经;柴胡、香附行气解郁;炒酸枣仁、黄柏清热除烦、凉血安神。二诊,患者气滞血瘀症状减轻,流鼻血,小便黄,故去柴胡、香附、红花、桃仁,加白茅根、川牛膝、蒲公英清热凉血,引血下行;睡眠、心情改善,去焦栀子,大便质稀,日行 3~5 次,加生薏苡仁健脾止泻。三诊,患者见舌尖有红点,脉沉略数,属阴虚火旺,热入营血,故加菟丝子、杜仲补肾益精;白芍、丹参凉血活血。纵观本案治法,以补肾活血为主,补肾方用六味地黄丸加减,填精益阴补肾,血瘀方用桃红四物汤加减,养血活

血,全方共奏补肾活血、养血调经之效。

4 小结

月经病是妇科最常见的疾患,不仅直接影响女性自身健康,而且还会影响胎孕,乃至妨碍优生优育,不可等闲视之。女子以血为主,气虚、气滞、寒热、痰湿均可致瘀,且受现代外部环境及自身不良习惯的影响,使月经病患者多形成以血瘀为主的复合型体质。体质决定着疾病证候的类型并影响疾病的发生,田老师在诊月经病时以辨体质为治疗特色,临证时详细审查患者的体质禀赋,针对性地治疗,收效甚好。经过多年临床经验,形成了固定的经验方,临床应用时随证加减,灵活方便,其临证经验及辨证思路值得我们学习。

【参考文献】

- [1] 冯多兰,李德非. 中医妇科学[M]. 长春:吉林人民出版社,2015: 97.
- [2] 张介宾. 景岳全书[M]. 崔之秋,校注. 北京:中国中医药出版社,1994:351-441.
- [3] 沈金鳌. 妇科五尺[M]. 郭福华,校注. 天津:天津科学技术出版社,2000:15.
- [4] 薛钰. 拜元是保[M]. 林士衡,周昱,谭依丽,等校注. 北京:中国中医药出版社,2015:14.
- [5] 万全. 万病回春全书[M]. 张清源,校注. 北京:中国中医药出版社,1996:337.
- [6] 佚名. 灵枢经[M]. 刘更生,校注. 北京:中国中医药出版社,2006:170.
- [7] 王清任. 医林改错[M]. 石学文,校注. 沈阳:辽宁科学技术出版社,1997:13.
- [8] 吴谦. 医宗金鉴[M]. 闫志安,包遵,校注. 北京:中国中医药出版社,1994:524.
- [9] 马希,马少卿,杨象萍. 基于田代英教授临证经验的三焦辨证体系研究[J]. 四川中医,2016,34(3):3-4.
- [10] 马宝璋,齐颖. 中医妇科学[M]. 北京:中国中医药出版社,2012: 80.

(上接第 908 页)

- [5] 于斯文,王晓红,曹敬吉. 针刺配合五音疗法治疗肝气郁结型抑郁症的临床观察[J]. 针灸临床杂志,2015,31(4):15-17.
- [6] 王恩强. 五行音乐对脑卒中恢复期抑郁患者的康复效果研究[D]. 福州:福建中医药大学,2015.
- [7] 王保甲,宋明娟,刘翠娟,等. 中西医结合治疗中风后抑郁 36 例[J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2006,4(4):364-365.
- [8] 梁仁超,唐海坤,朱继孝,等. 中国五行音乐对抑郁模型小鼠行为及脑内 5-HT 染色和去甲肾上腺素影响的实验研究[J]. 中国康复医学杂志,2015,30(7):713-714.
- [9] 林法财,黄德弘,黄宇斌,等. 五行音乐治疗脑卒中抑郁患者
- 的有效性及其安全性研究[J]. 中国康复医学杂志,2017,32(12): 1300-1303.
- [10] 徐虹,孙霞人,李前华,等. 针刺治疗抑郁及其对患者下丘脑-垂体-肾上腺轴的影响[J]. 中国针灸,2009,29(2):78-80.
- [11] 崔淑娟,王玲玲,吕楠,等. 针刺对抑郁模型大鼠前额皮质单胺类神经递质的影响[J]. 中国临床康复,2006,10(15):129-131.
- [12] 谢朝霞,王红,李利智,等. 五行音乐干预对脑卒中后抑郁患者生活质量的影响[J]. 现代中西医结合杂志,2016,25(6): 677-679.